BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Quy trình kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

Bản hoàn thiện để trình thẩm định năm 2026

Rà soát ngày 15/10/2026. Gồm 42 quy trình từ bản năm 2024 do bệnh viện cung cấp, chuẩn hóa đề cương QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 và bổ sung kiểm soát an toàn. Bản nguồn được giữ nguyên.

Bản trình thẩm định chưa phải tài liệu ban hành. Khoa và Hội đồng chuyên môn xác nhận nội dung theo hướng dẫn hiện hành, phạm vi kỹ thuật và thiết bị thực tế trước áp dụng; mã tài liệu là đề xuất.

Nội dung	Xác nhận
Người biên soạn	……
Người thẩm định chuyên môn	……
Người phê duyệt	……
Số quyết định và ngày hiệu lực	……

Căn cứ và phạm vi rà soát

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 quy định đề cương và thể thức, không quy định mọi thao tác lâm sàng. Mỗi quy trình có 7 phần, chuẩn bị gồm 5.1–5.9.

Bộ Y tế ban hành bộ PHCN theo QĐ3553, QĐ3554 và QĐ3555/QĐ-BYT ngày 14/11/2025. Công văn 3037/SYT-NVY ngày 17/11/2025 của Sở Y tế An Giang triển khai ba quyết định: Tập 2 có hiệu lực từ 01/7/2026; Tập 1 và Tập 3 từ ngày ký.

Bản năm 2024 dẫn QĐ54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 và QĐ3109/QĐ-BYT ngày 19/8/2014. Không dùng trích dẫn cũ làm căn cứ duy nhất. Đã xác minh bộ năm 2025 từ cơ quan y tế nhưng chưa truy cập đủ toàn văn để đối chiếu tương ứng từng kỹ thuật; bản này không xác nhận đã cập nhật đủ 42 quy trình theo bộ 2025.

Kế thừa thao tác phù hợp từ bản bệnh viện, sửa lỗi rõ ràng, bổ sung thận trọng, chuẩn bị, điểm dừng và theo dõi. Liều năng lượng, lực kéo, thời gian và chế độ tập phải được bác sĩ chỉ định theo hướng dẫn chuyên ngành và đúng thiết bị; không đặt liều chung cho mọi người.

Loại bỏ chiếu laser vào giác mạc, công suất MW, kéo tay hoặc nách nâng người, tập kéo vượt đau, cố định mọi tổn thương 21 ngày và lịch kiểm tra tế bào máu chung cho mọi máy sóng ngắn. Phân biệt đúng phiên bản thang lượng giá.

Trước ban hành, khoa đối chiếu từng kỹ thuật với bộ 2025, xác nhận chỉ định, chống chỉ định, thời gian, thông số, nhân lực và phạm vi hành nghề. Bổ sung hướng dẫn thiết bị, thang đo chuẩn và cấp cứu. Kéo nắn xung lực hoặc cột sống cổ cần quy trình chuyên biệt và năng lực xác nhận; không triển khai chỉ từ mô tả tổng hợp.

Tài liệu đối chiếu

1. Sở Y tế An Giang, Công văn 3037/SYT-NVY ngày 17/11/2025. Nguồn đối chiếu

2. Trung tâm Y tế Quy Nhơn công bố Tập 1 theo QĐ3553/QĐ-BYT. Nguồn đối chiếu

3. Trung tâm Y tế Quy Nhơn công bố Tập 2 theo QĐ3554/QĐ-BYT. Nguồn đối chiếu

4. Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu công bố Tập 3 theo QĐ3555/QĐ-BYT. Nguồn đối chiếu

5. OSHA hướng dẫn an toàn laser, đối chiếu nguy cơ mắt và kính bảo vệ; không phải quy định Việt Nam. Nguồn đối chiếu

Danh mục quy trình

Quy trình 01 đến 21	Quy trình 22 đến 42
01 Điều trị bằng các dòng điện xung	22 Tập với thang tường
02 Điều trị bằng siêu âm	23 Tập với ròng rọc
03 Điều trị bằng tia hồng ngoại nhân tạo	24 Tập với dụng cụ quay khớp vai
04 Điều trị bằng laser công suất thấp	25 Tập với giàn treo các chi
05 Điều trị bằng parafin	26 Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi
06 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống	27 Tập với xe đạp tập
07 Tập vận động thụ động	28 Tập thăng bằng với bàn bập bênh
08 Tập vận động có trợ giúp	29 Kỹ thuật kéo nắn trị liệu
09 Tập vận động chủ động	30 Kỹ thuật di động khớp
10 Tập vận động có kháng trở	31 Kỹ thuật di động mô mềm
11 Tập kéo giãn	32 Xoa bóp trị liệu
12 Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người	33 Tập cơ đáy chậu
13 Tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người	34 Tập khéo léo bàn tay
14 Tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người	35 Tập phối hợp hai tay
15 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi	36 Tập sinh hoạt hằng ngày với dụng cụ trợ giúp
16 Tập thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng	37 Tập phát âm
17 Tập dáng đi	38 Tập cho người bệnh thất ngôn
18 Tập đi trong thanh song song	39 Lượng giá hoạt động sinh hoạt hằng ngày
19 Tập đi với khung tập đi	40 Lượng giá chức năng lao động và hướng nghiệp
20 Tập lên xuống cầu thang	41 Điều trị bằng sóng xung kích
21 Tập vận động trên bóng	42 Điều trị bằng sóng ngắn

01 Điều trị bằng các dòng điện xung

Mã đề xuất QT VLTL 01 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Dòng điện xung là dòng điện do nhiều xung điện liên tiếp tạo nên. Trong vật lý trị liệu thường sử dụng các dòng điện xung có dạng xung và tần số khác nhau một chiều (nửa sóng) và xoay chiều (cả sóng).

2 Chỉ định

- Giảm đau sau chấn thương, phẫu thuật, đau thần kinh, đau cơ, xương, khớp…
- Kích thích thần kinh cơ.
- Cải thiện tuần hoàn ngoại vi.

3 Chống chỉ định

- Người bệnh mang máy tạo nhịp tim.
- Sốt cao, khối u ác tính, bệnh lao đang tiến triển.
- Mất cảm giác ở vùng điều trị. Tổn thương da nơi đặt điều trị
- Viêm da khu trú, huyết khối, viêm tắc mạch
- Trực tiếp lên thai nhi

4 Thận trọng

Kiểm tra thai kỳ, thiết bị cấy ghép, cảm giác và tưới máu tại vùng điều trị; chỉ định phải phù hợp từng phương thức và model. Không bắt đầu khi chưa rõ hướng dẫn sử dụng hoặc thông số được chỉ định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Điện cực, tấm lót hoặc gel tương thích.

5.4 Trang thiết bị

Máy điện xung và phụ kiện đã kiểm tra.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu. Kiểm tra da, cảm giác, tưới máu và vật cản vùng điều trị theo yêu cầu phương thức.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Đặt và cố định điện cực: theo chỉ định.

+ Đặt các thông số kỹ thuật theo chỉ định.

Tăng cường độ từ từ theo chế độ, mục tiêu và khả năng dung nạp; giảm đau không mặc định phải gây co cơ. Kích thích cơ áp dụng đáp ứng theo chỉ định.

- Hết giờ tắt máy bằng tay hoặc tự động:

Tháo điện cực kiểm tra da vùng điều trị, thăm hỏi người bệnh ghi hồ sơ bệnh án.

Đưa cường độ về không trước đặt lại hoặc tháo điện cực; ghi chế độ, vị trí, thông số và đáp ứng.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Cảm giác và phản ứng người bệnh

- Hoạt động của máy.

- Điện giật: xử trí cấp cứu điện giật.

Bỏng hoặc tổn thương da: đưa cường độ về không, ngắt nguồn an toàn, đánh giá và báo bác sĩ; xử trí theo loại bỏng. Không tự trung hòa acid hoặc kiềm trên da.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Sự cố điện: ngắt nguồn an toàn trước tiếp cận, gọi hỗ trợ, cấp cứu theo tình trạng. Bỏng hoặc đau rát: dừng nguồn năng lượng, đánh giá, báo bác sĩ; cách ly máy lỗi và báo bộ phận thiết bị.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

02 Điều trị bằng siêu âm

Mã đề xuất QT VLTL 02 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Siêu âm là sóng âm thanh có tần số trên 20.000 Hz. Trong điều trị thường dùng siêu âm tần số 1 và 3 MHz với tác dụng chính sóng cơ học, tăng nhiệt và sinh học. Các kỹ thuật chính: trực tiếp, qua nước, siêu âm dẫn thuốc

2 Chỉ định

- Giảm đau cục bộ

Giãn cơ, giảm co thắt theo chỉ định.

- Viêm mãn tính.
- Xơ cứng, sẹo nông ở da.

Siêu âm dẫn thuốc chỉ khi có chỉ định riêng, thuốc phù hợp và quy trình đã duyệt.

3 Chống chỉ định

- Trực tiếp lên các u, tinh hoàn, buồng trứng, thai nhi.
- Không điều trị trên tinh hoàn, tử cung đang có thai, đang hành kinh.
- Trực tiếp vùng khớp ở trẻ em.
- Không điều trị trên các đầu xương của trẻ em, nhất là phần sụn.
- Viêm tắc mạch.
- Không điều trị vùng phổi người bị lao đang tiến triển hoặc viêm hạch do lao.
- Viêm da cấp.
- Không điều trị vùng phổi người bệnh bị giãn phế quản.
- Trực tiếp vùng chảy máu, đe dọa chảy máu.

4 Thận trọng

Kiểm tra thai kỳ, thiết bị cấy ghép, cảm giác và tưới máu tại vùng điều trị; chỉ định phải phù hợp từng phương thức và model. Không bắt đầu khi chưa rõ hướng dẫn sử dụng hoặc thông số được chỉ định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện. Dẫn thuốc cần chỉ định riêng, xác nhận thuốc phù hợp và quy trình đã duyệt.

5.3 Vật tư

Gel tiếp âm, khăn, vật tư cách ly khi cần.

5.4 Trang thiết bị

Máy siêu âm và đầu phát; chậu chuyên dụng nếu chỉ định qua nước.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu. Kiểm tra da, cảm giác, tưới máu và vật cản vùng điều trị theo yêu cầu phương thức.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Đặt các thông số kỹ thuật và cách điều trị theo chỉ định.

Dùng môi trường tiếp âm tương thích; áp đầu phát đúng vùng, duy trì tiếp xúc và di chuyển đều theo kỹ thuật được chỉ định, không để đứng yên một điểm khi phát năng lượng.

- Hết giờ tắt máy (bằng tay hoặc tự động).

- Kiểm tra vùng điều trị, thăm hỏi người bệnh, ghi chép hồ sơ.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Cảm giác và phản ứng người bệnh.

- Hoạt động của máy.

- Điện giật: Tắt máy và xử trí theo quy định.

Dị ứng tại chỗ, đau sâu hoặc nóng rát: dừng phát, kiểm tra da, môi trường tiếp âm và thông số; báo bác sĩ xử trí.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Sự cố điện: ngắt nguồn an toàn trước tiếp cận, gọi hỗ trợ, cấp cứu theo tình trạng. Bỏng hoặc đau rát: dừng nguồn năng lượng, đánh giá, báo bác sĩ; cách ly máy lỗi và báo bộ phận thiết bị.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

03 Điều trị bằng tia hồng ngoại nhân tạo

Mã đề xuất QT VLTL 03 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Hồng ngoại nguồn nhân tạo do (các loại đèn hồng ngoại phát ra có công suất khác nhau. Tác dụng chủ yếu là nhiệt nóng.

2 Chỉ định

- Giảm đau, giãn cơ, tăng cường lưu thông máu, ngoại vi.
- Chống viêm: mạn tính, - Sưởi ấm.

3 Chống chỉ định

- Vùng da vô mạch, mất cảm giác.
- Các bệnh ngoài da cấp tính.

4 Thận trọng

Kiểm tra thai kỳ, thiết bị cấy ghép, cảm giác và tưới máu tại vùng điều trị; chỉ định phải phù hợp từng phương thức và model. Không bắt đầu khi chưa rõ hướng dẫn sử dụng hoặc thông số được chỉ định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Khăn, vật che bảo vệ da và mắt theo hướng dẫn.

5.4 Trang thiết bị

Đèn hồng ngoại y tế, giá đỡ, hẹn giờ.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu. Kiểm tra da, cảm giác, tưới máu và vật cản vùng điều trị theo yêu cầu phương thức.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Chiếu đèn theo các theo các thông số chỉ định (công suất đèn, khoảng cách, thời gian)

- Kiểm tra da vùng điều trị, thăm hỏi người bệnh, ghi chép hồ sơ.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Cảm giác và phản ứng người bệnh.

- Bỏng da xử trí theo phác đồ.

- Choáng váng: nằm nghỉ ngơi theo dõi

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Sự cố điện: ngắt nguồn an toàn trước tiếp cận, gọi hỗ trợ, cấp cứu theo tình trạng. Bỏng hoặc đau rát: dừng nguồn năng lượng, đánh giá, báo bác sĩ; cách ly máy lỗi và báo bộ phận thiết bị.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

04 Điều trị bằng laser công suất thấp

Mã đề xuất QT VLTL 04 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Laser công suất thấp sử dụng bước sóng và công suất theo thiết bị. Ghi đúng đơn vị mW hoặc W theo nhãn máy; không sử dụng mức 10–30 MW của bản cũ làm thông số điều trị.

2 Chỉ định

- Chống viêm, chống phù nề nông.

- Kích thích tái tạo mô, làm liền vết thương, vết loét.
- Giảm đau cục bộ.
- Châm cứu bằng laser.

3 Chống chỉ định

- Sốt cao, u ác tính
- Chiếu trực tiếp vào mắt.
- Đang chảy máu.

4 Thận trọng

Không chiếu trực tiếp hoặc phản xạ vào mắt. Kiểm soát vùng chiếu, vật phản quang và kính đúng bước sóng, mật độ quang học cho mọi người trong vùng; kính râm không thay kính laser.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Kính laser đúng bước sóng và mật độ quang học.

5.4 Trang thiết bị

Máy laser, đầu chiếu và cảnh báo vùng kiểm soát.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu. Kiểm tra da, cảm giác, tưới máu và vật cản vùng điều trị theo yêu cầu phương thức.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Chọn các tham số kỹ thuật theo chỉ định

Không hướng tia trực tiếp hoặc phản xạ vào mắt, kể cả chiếu tiếp tuyến giác mạc. Dùng kính bảo vệ đúng bước sóng và mật độ quang học cho người bệnh và người trong vùng kiểm soát.

- Hết giờ điều trị: tắt đèn kiểm tra vùng da chiếu, thăm hỏi người bệnh, ghi chép phiếu.

Kiểm tra kính, vùng kiểm soát và thông số trước phát; tắt phát trước di chuyển đầu hoặc tháo kính, ghi bước sóng, công suất và liều theo máy.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Hoạt động của máy, các thông số, chùm tia.

- Phản ứng và cảm giác của người bệnh

Không nhìn trực tiếp vào chùm tia; chọn kính theo bước sóng, mật độ quang học và phân loại nguy cơ của máy, không theo màu kính.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Sự cố điện: ngắt nguồn an toàn trước tiếp cận, gọi hỗ trợ, cấp cứu theo tình trạng. Bỏng hoặc đau rát: dừng nguồn năng lượng, đánh giá, báo bác sĩ; cách ly máy lỗi và báo bộ phận thiết bị.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

05 Điều trị bằng parafin

Mã đề xuất QT VLTL 05 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Parafin là phương tiện nhiệt nông. Nhiệt độ nấu chảy không phải nhiệt độ được phép áp trực tiếp lên da; đo nhiệt độ tiếp xúc và đối chiếu hướng dẫn thiết bị trước sử dụng.

- Có nhiều kỹ thuật điều trị parafin, chỉ đề cập điều trị parafin đắp ngoài

2 Chỉ định

- Giảm đau giãn cơ

- Viêm mạn tính

- Giãn mạch ngoại vi, tăng tuần hoàn cục bộ

3 Chống chỉ định

- Chấn thương cấp, nhiễm trùng cấp

Đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu tại vùng điều trị.

- Sốt cao, quá suy kiệt
- Di ứng với parafin, bệnh ngoài da
- Mất cảm giác

4 Thận trọng

Giảm cảm giác, tưới máu hoặc không thể phản hồi tăng nguy cơ bỏng. Đo nhiệt độ theo hướng dẫn và quan sát da; cảm giác nóng của nhân viên không đủ xác nhận an toàn.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Parafin y tế, khay, vật liệu bọc và khăn.

5.4 Trang thiết bị

Thiết bị parafin kiểm soát nhiệt, nhiệt kế.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu. Kiểm tra da, cảm giác, tưới máu và vật cản vùng điều trị theo yêu cầu phương thức.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

Làm nóng parafin bằng thiết bị chuyên dụng, đo nhiệt độ và chuẩn bị miếng đắp theo hướng dẫn; kiểm tra da và cảm giác trước áp.

Đắp khi đạt nhiệt độ tiếp xúc an toàn theo hướng dẫn, phủ vật liệu bảo vệ phù hợp; không dùng bao cát gây chèn ép vùng làm nóng.

Quy trình này áp dụng đắp ngoài. Nhúng hoặc quét cần hướng dẫn riêng và kiểm soát lây nhiễm phù hợp.

+ Thời gian theo chỉ định

+ Kết thúc điều trị: gỡ parafin kiểm tra lau khô, dặn dò người bệnh, ghi phiếu điều trị

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Cảm giác và phản ứng người bệnh
- Sau điều trị dị ứng mẩn ngứa
- Bỏng nhẹ (vùng da mỏng, trong parafin có nước): xử trí theo phác đồ
- Dị ứng với parafin: ngừng điều trị, xử trí theo phác đồ, kiểm tra parafin (có lẫn hóa chất không) cần làm sạch tuân theo quy định

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Sự cố điện: ngắt nguồn an toàn trước tiếp cận, gọi hỗ trợ, cấp cứu theo tình trạng. Bỏng hoặc đau rát: dừng nguồn năng lượng, đánh giá, báo bác sĩ; cách ly máy lỗi và báo bộ phận thiết bị.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

06 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống

Mã đề xuất QT VLTL 06 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Kéo giãn cột sống bằng máy dựa trên nguyên lý cơ học có điều chỉnh kéo, chế độ, thời gian theo yêu cầu lên cột sống

2 Chỉ định

- Thoái hóa cột sống
- Thoát vị đĩa đệm giai đoạn đầu, thoát vị đĩa đệm vừa và nhẹ
- Hội chứng đau lưng và thắt lưng do nguyên nhân ngoại vi (cơ, dây chằng).
- Vẹo cột sống do tư thế

3 Chống chỉ định

- Tổn thương thực thể cột sống: ung thư, lao, viêm tấy áp xe vùng lưng
- Chấn thương cột sống có gãy xương biến dạng
- Bệnh lý tủy sống và ống sống
- Thoái hóa cột sống có các cầu xương nối các đốt sống
- Viêm cột sống dính khớp
- Loãng xương nặng
- Người bệnh già, suy kiệt
- Trẻ em
- Cao huyết áp, các bệnh tim nặng
- Phụ nữ có thai, đang có kinh nguyệt

4 Thận trọng

Sàng lọc chèn ép tủy hoặc đuôi ngựa, mất vững, gãy, u, nhiễm trùng, thiếu hụt thần kinh tiến triển. Thử nút dừng khẩn và giám sát đáp ứng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Đai đúng cỡ và đệm bảo vệ.

5.4 Trang thiết bị

Máy, giường kéo, nút dừng khẩn.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu. Kiểm tra da, cảm giác, tưới máu và vật cản vùng điều trị theo yêu cầu phương thức.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Xác nhận chỉ định, vùng cột sống, chống chỉ định; ghi đau và tình trạng thần kinh trước kéo.

Bước 2. Kiểm tra máy, đai, giường và thử nút dừng khẩn; hướng dẫn người bệnh sử dụng và gọi hỗ trợ.

Bước 3. Đặt tư thế, cố định đúng vùng và thiết bị, kiểm tra da, tránh chèn ép hô hấp hoặc tuần hoàn.

Bước 4. Cài lực, góc, chế độ, chu kỳ và thời gian theo y lệnh cùng hướng dẫn máy; khởi động từ từ, theo dõi và không để người bệnh thiếu phương tiện gọi hỗ trợ.

Bước 5. Giảm lực và dừng đúng trình tự trước tháo đai; đánh giá lại đau, cảm giác và vận động, ghi thông số và đáp ứng.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Cảm giác và phản ứng của người bệnh

Tình trạng hoạt động của máy

- Đau chói vùng kéo: ngừng kéo, kiểm tra theo dõi, xử trí theo phác đồ

- Đau tăng dần và kéo dài: kiểm tra theo dõi

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Sự cố điện: ngắt nguồn an toàn trước tiếp cận, gọi hỗ trợ, cấp cứu theo tình trạng. Bỏng hoặc đau rát: dừng nguồn năng lượng, đánh giá, báo bác sĩ; cách ly máy lỗi và báo bộ phận thiết bị.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

07 Tập vận động thụ động

Mã đề xuất QT VLTL 07 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

- Tập thụ động là hình thức tập được thực hiện bởi lực tác động bên ngoài do người tập hoặc các dụng cụ trợ giúp. Vận động thụ động nghĩa là phần cơ thể được vận động không có sự tham gia làm động tác vận động co cơ chủ động của người bệnh.

- Kỹ thuật này được làm khi người bệnh không tự thực hiện được động tác vận động của mình.

2 Chỉ định

Khi người bệnh không tự làm được động tác vận động.

3 Chống chỉ định

Khi có nguy cơ biến chứng do vận động thụ động gây ra:

- Gãy xương, can xương độ I hoặc II

Sau chấn thương hoặc phẫu thuật không vận động vượt giới hạn bất động, chịu tải hoặc tầm vận động do bác sĩ quy định.

- Nguy cơ gãy xương như u xương, lao xương, lao khớp
- Viêm khớp nhiễm khuẩn, tràn máu, tràn dịch khớp
- Các vết thương phần mềm quanh khớp chưa liền sẹo

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Khăn, gối nâng đỡ.

5.4 Trang thiết bị

Bàn tập và dụng cụ đo tầm vận động.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Tư thế người bệnh thoải mái phù hợp với khớp cần tập.

- Không dùng lực bắt khớp cần tập vận động.

- Người làm kỹ thuật thực hiện vận động theo mẫu, theo tầm vận động bình thường của khớp, đoạn chi hoặc phần cơ thể đó.

- Tần suất Thời gian một lần tập 15-20 phút cho một khớp, 1- 2 lần/ ngày, tùy theo bệnh cảnh lâm sàng và tình trạng thực tế của người bệnh.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

1. Trong khi tập

- Phản ứng của người bệnh: khó chịu, đau.

- Các dấu hiệu chức năng sống: mạch, huyết áp, nhịp thở.

- Các thay đổi bất thường: nhiệt độ, màu sắc đoạn chi, tầm vận động, chất lượng vận động.

2. Sau khi tập

- Các dấu hiệu sống: mạch, huyết áp, nhịp thở, tình trạng toàn thân chung.

Đau tăng, sưng hoặc mệt kéo dài sau tập: báo bác sĩ điều chỉnh. Đau cấp, biến dạng hoặc dấu hiệu thần kinh mạch máu cần dừng và đánh giá ngay.

- Nhiệt độ, màu sắc da, tầm vận động, chất lượng vận động của đoạn chi cần tập.

1. Trong khi tập

- Đau: không tập vận động vượt quá tầm vận động bình thường của khớp hoặc chi đó.

- Hạ huyết áp, ngừng tim, ngừng thở, gãy xương, trật khớp: ngừng tập và xử trí cấp cứu ngay.

2. Sau khi tập: xử trí phù hợp với tai biến xảy ra

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

08 Tập vận động có trợ giúp

Mã đề xuất QT VLTL 08 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Vận động có trợ giúp là loại vận động chủ động do chính người bệnh thực hiện cùng với sự hỗ trợ của người khác hoặc các dụng cụ trợ giúp tập luyện để cho người bệnh hoàn thiện được động tác vận động.

2 Chỉ định

Trong mọi trường hợp người bệnh chưa tự thực hiện được hết tầm vận động của khớp, một phần động tác vận động của mình.

3 Chống chỉ định

- Gãy xương mới
- Viêm khớp nhiễm khuẩn, lao khớp, tràn máu, tràn dịch khớp
- Chấn thương mới (1-2 ngày đầu), sai khớp chưa được nắn chỉnh
- Không làm được động tác hoặc làm được động tác lại nặng thêm.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Gối, dụng cụ trợ giúp.

5.4 Trang thiết bị

Bàn tập hoặc hệ thống trợ lực theo chỉ định.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Người bệnh ở các tư thế thích hợp cho bài để tập.

- Người tập ở các tư thế phù hợp.

- Tiến hành tập luyện: Yêu cầu người bệnh vận động chủ động phần cơ thể cần vận động như tự thực hiện phần vận động chân, tay hoặc phần cơ thể cần PHCN mà tự họ làm được, người điều trị trợ giúp để người bệnh thực hiện được tối đa tầm vận động của khớp phần động tác mà họ không tự làm được. Có thể sử dụng các dụng cụ PHCN trợ giúp vận động của người bệnh.

- Mỗi ngày tập 1 đến 2 lần, mỗi lần tập 20 đến 30 phút.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

1. Trong khi tập

- Xem người bệnh có đau, khó chịu.

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở và tình trạng toàn thân.

2. Sau khi tập

Đau tăng hoặc kéo dài sau tập: đánh giá và điều chỉnh; dấu hiệu tổn thương cấp phải dừng và báo bác sĩ ngay.

- Theo dõi tiến triển của tầm vận động khớp.

1. Trong khi tập: Nếu người bệnh bị đau tăng thì ngừng tập và theo dõi thêm.

2. Sau khi tập: Nếu đau kéo dài và tình trạng toàn thân người bệnh có biểu hiện bất thường nếu do tập quá mức, phải xử trí tai biến và giảm cường độ tập các lần sau cho phù hợp thì ngừng tập và xử trí tai biến đó.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

09 Tập vận động chủ động

Mã đề xuất QT VLTL 09 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Là động tác vận động do chính người bệnh thực hiện mà không cần có sự trợ giúp. Đây là phương pháp phổ biến chủ động và có hiệu quả nhất, nhằm mục đích duy trì và tăng tầm vận động của khớp, tăng sức mạnh của cơ.

2 Chỉ định

- Người bệnh đã tự thực hiện được vận động.
- Kết quả thử cơ từ bậc 2 trở lên, cần làm tăng sức mạnh của cơ.

3 Chống chỉ định

- Người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp. Tình trạng tim mạch không ổn định
- Khi vận động khớp sẽ làm tổn thương phần khác của cơ thể.
- Ngay sau phẫu thuật khớp, gân, cơ, dây chằng hoặc vá da ngang qua khớp.
- Gãy xương, trật khớp chưa xử trí.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày, trang phục, gối.

5.4 Trang thiết bị

Giường, ghế hoặc dụng cụ theo tư thế.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Người bệnh: tư thế thoải mái, phù hợp với mục đích, kỹ thuật và các phần của cơ thể cần tập, cho phép vận động các khớp, chi trong tầm vận động bình thường. Động viên người bệnh chủ động vận động trong tầm được phép và không đau.

- Người hướng dẫn tập: tư thế thoải mái thuận tiện cho các thao tác, làm động tác mẫu hướng dẫn người bệnh tập.

- Kỹ thuật: tập vận động theo các mẫu và tầm vận động bình thường của khớp, chi, phần cơ thể.

- Mỗi động tác lặp lại nhiều lần tùy theo khả năng người bệnh. Thời gian tập và mức độ vận động vận tăng dần, bắt đầu từ 5 đến 10 vận động. Tầm tập theo giới hạn an toàn của từng người bệnh. Mỗi ngày tập 1 đến 2 lần.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

1. Trong khi tập: chất lượng của vận động, phản ứng của người bệnh, mạch, huyết áp, nhịp thở.

Đau tăng hoặc kéo dài sau tập: giảm hoặc dừng can thiệp, đánh giá và báo bác sĩ. Đau cấp, sưng, biến dạng hoặc bất thường thần kinh mạch máu cần xử trí ngay, không chờ đủ một khoảng thời gian cố định.

1. Trong khi tập

- Đau: không vận động quá tầm vận động cho phép của khớp hoặc phần cơ thể cần tập.

- Gãy xương, trật khớp: ngừng tập, xử trí gãy xương, trật khớp.

- Hạ huyết áp, ngừng tim, ngừng thở: ngừng tập, cấp cứu hạ huyết áp, ngừng tim, ngừng thở.

Đau tăng hoặc kéo dài sau tập: giảm hoặc dừng can thiệp, đánh giá và báo bác sĩ. Đau cấp, sưng, biến dạng hoặc bất thường thần kinh mạch máu cần xử trí ngay, không chờ đủ một khoảng thời gian cố định.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

10 Tập vận động có kháng trở

Mã đề xuất QT VLTL 10 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Tập vận động có kháng trở là vận động chủ động trong đó sự co cơ động hay tĩnh bị kháng lại bằng một lực từ bên ngoài. Mục đích làm tăng sức mạnh của cơ, tăng sức bền của cơ, tăng công của cơ.

2 Chỉ định

Cần làm tăng sức mạnh và sức bền của cơ.

3 Chống chỉ định

- Trong trường hợp đã được lượng giá thử cơ bậc 0,1,2.
- Trong bệnh lý teo cơ giả phì đại.
- Thận trọng trong một số trường hợp bệnh lý nội khoa, tim mạch nặng, suy hô hấp, chấn thương chưa bình phục.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Dây kháng lực, tạ định mức khi chỉ định.

5.4 Trang thiết bị

Bàn, ghế và dụng cụ lượng giá sức cơ.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Tư thế người bệnh

Người bệnh ở tư thế thoải mái, phù hợp với vị trí cần tập, không làm hạn chế tầm vận động trong khi tập.

2. Nguyên tắc kỹ thuật

- Lực kháng cản được đặt cố định ở đầu xa của cơ cần được làm mạnh hoặc ở điểm xa của khối cử động.

Lực kháng đối ngược hướng vận động dự kiến, đặt trên đoạn chi phù hợp và tăng dần; tránh lực xoắn hoặc áp lực bất thường lên khớp.

- Người bệnh không được nín thở trong khi tập.

3. Kỹ thuật

- Tập vận động có kháng trở đẳng trương (isotonic).

- Bài tập vận động có kháng trở đẳng trường (isometric).

- Nguyên tắc chung:

+ Đúng kỹ thuật.

+ An toàn.

+ Hiệu quả.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

1. Trong khi tập: mạch, huyết áp, nhịp thở và các biểu hiện bất thường khác.

2. Sau khi tập: có mệt mỏi, đau kéo dài do tập quá sức.

1. Trong khi tập: theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở và các biến chứng khác để xử trí kịp thời.

2. Sau khi tập: sau khi tập 24 giờ nếu người bệnh còn đau, mệt phải báo cáo bác sĩ chuyên khoa để xử trí và điều chỉnh chương trình tập cho phù hợp.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an

toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

11 Tập kéo giãn

Mã đề xuất QT VLTL 11 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

1. Định nghĩa

Kéo dãn là một kỹ thuật được sử dụng để kéo dài cấu trúc mô mềm bị co ngắn do giảm hay mất tính mềm dẻo, tính đàn hồi, làm gia tăng tầm vận động khớp. Có hai phương pháp để kéo dài các tổ chức co được (cơ) và tổ chức không co được (tổ chức liên kết), đó là kéo dãn thụ động và tự kéo dãn.

- Kéo dãn thụ động:

Là phương pháp có thể tác động kéo dài cả hai tổ chức co được và không co được.

+ Kéo dãn thụ động bằng tay

Sử dụng lực ngoại lai của người điều trị để kiểm soát hướng đi, tốc độ, cường độ, thời gian kéo dãn đối với các tổ chức mô mềm bị co rút làm hạn chế tầm vận động khớp. Kéo dãn thụ động bằng tay là phương pháp kéo dãn có thời gian ngắn, kết quả đạt được về tầm vận động là nhất thời.

+ Kéo dãn thụ động bằng cơ học dụng cụ

Kỹ thuật này phải sử dụng các loại dụng cụ bằng cơ học để cung cấp lực kéo dãn.

- Tự kéo dãn:

Tự kéo dãn là kỹ thuật mà người bệnh tự thực hiện để kéo dãn một cách thụ động những cơ co rút của chính họ bằng cách sử dụng trọng lượng cơ thể như lực để kéo dãn.

2 Chỉ định

- Tầm vận động khớp bị hạn chế do co rút, dính khớp và hình thành sẹo tổ chức, dẫn đến các cơ, tổ chức liên kết, da bị co ngắn lại.

- Phòng ngừa các biến dạng cấu trúc, co rút phần mềm do hạn chế tầm vận động khớp

- Co cứng, co rút làm giới hạn các hoạt động chức năng hàng ngày.

- Yếu cơ và các tổ chức bị căng. Các tổ chức bị căng được kéo dài trước khi tập mạnh cơ yếu thì hiệu quả tập mạnh cơ sẽ tốt hơn.

3 Chống chỉ định

1. Chống chỉ định

- Khi có khối xương (cơ hóa cốt, u xương...) làm giới hạn tầm vận động khớp.

- Người bệnh sau gãy xương mới.

- Viêm cấp tính, nhiễm trùng trong khớp hoặc quanh khớp.

- Bất cứ khi nào cơ đau nhói, đau cấp tính khi cử động khớp hoặc khi kéo dài cơ.

- Khi có khối máu tụ hoặc các dấu hiệu khác của chấn thương phần mềm.
- Khi sự co cứng hoặc co ngắn của các mô mềm tạo nên sự ổn định khớp vì lúc này không thể ổn định khớp bằng độ bền vững của cấu trúc và sức mạnh cơ bình thường.
- Khi co cứng hoặc co ngắn các mô mềm là cơ sở để tăng các khả năng chức năng, đặc biệt trong trường hợp người bệnh bị liệt nặng.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

- Không kéo dãn bắt buộc khớp vượt quá tầm vận động bình thường của khớp nó một cách thụ động.
- Thận trọng khi kéo dãn ở những trường hợp gãy xương mới, ổ gãy phải được bảo vệ bằng cách cố định giữa nơi gãy và khớp vận động.
- Thận trọng khi kéo dãn ở những người bệnh có hay nghi ngờ loãng xương nặng do bệnh lý, do nằm lâu, do tuổi hay do sử dụng thuốc.
- Lưu ý là các bài tập kéo dãn cơ cường độ cao trong thời gian ngắn thường làm chấn thương và hậu quả làm yếu các mô mềm.
- Bổ sung các bài tập tăng cường sức mạnh vào chương trình kéo dãn để người bệnh có thể phát triển sự cân bằng thích hợp giữa độ mềm dẻo và sức mạnh.
- Nếu người bệnh đau khớp hoặc nhức cơ kéo dài hơn 24 giờ là dấu hiệu của lực kéo dãn đã quá mức.
- Tránh kéo dãn các mô bị phù vì nó dễ tổn thương hơn mô bình thường, khi kéo dãn dễ gây đau và làm phù tăng lên.
- Tránh kéo dãn quá mức các cơ yếu đặc biệt các cơ nâng đỡ cơ thể trong mối tương quan với trọng lực.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Đai, khăn, gối.

5.4 Trang thiết bị

Bàn tập và dụng cụ đo tầm; kéo cơ học chỉ khi chỉ định.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ, lựa chọn kỹ thuật

Lựa chọn kỹ thuật kéo dãn để có thể đạt được mục đích tốt nhất.

2. Kiểm tra và chuẩn bị người bệnh

- Giải thích mục đích kéo dãn và quy trình kéo dãn cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

- Đặt người bệnh trong tư thế thoải mái, vững chắc và ổn định để cho phép mặt phẳng cử động là tốt nhất khi quy trình kéo dãn được thực hiện.

- Dùng các kỹ thuật thư giãn, nhiệt nóng đối với tổ chức mô mềm trước khi kéo dãn để làm tăng khả năng duỗi dài và giảm chấn thương.

3. Thực hiện kỹ thuật kéo dãn bằng tay

- Cử động chi thể chậm rãi qua phạm vi tự do của điểm bị hạn chế. Hướng kéo dãn sẽ ngược lại với hướng cơ bị co ngắn.

- Cầm nắm ở đoạn gần và đoạn xa đối với khớp tạo ra cử động. Nên sử dụng những miếng đệm lót ở vùng có tổ chức dưới da ít, trên mặt xương, nơi giảm cảm giác và sử dụng mặt phẳng rộng của bàn tay khi tạo lực.

- Khi kéo dãn cơ trên nhiều khớp, kéo dãn khớp gần trước, tiếp đến là khớp xa.

- Kéo dãn cơ qua một khớp ở một thời điểm, sau đó qua toàn bộ các khớp một cách đồng thời cho đến khi độ dài tối ưu của tổ chức mô mềm đạt được.

- Lực vừa đủ để tạo sức căng ở các cấu trúc của mô mềm nhưng không quá mạnh để gây đau hay tổn thương các cấu trúc này.

- Tránh các cử động giật cục, tránh để rơi tay chân đột ngột ở cuối tầm.

- Để lực kéo dãn kéo dài ít nhất 15-30 giây, trong thời gian này sức căng ở tổ chức sẽ giảm xuống, cử động của khớp và chi sẽ xa hơn một ít.

- Giảm dần lực kéo dãn để người bệnh nghỉ một lúc, sau đó lặp lại kỹ thuật.

- Chú ý đừng cố gắng đạt được hết tầm trong một hay hai đợt điều trị. Tăng tính mềm dẻo là một quá trình chậm và từ từ.

4. Thực hiện kéo dãn thụ động bằng dụng cụ cơ học

4.1. Kéo dãn thụ động bằng dụng cụ cơ học thời gian dài kéo dài

Kéo giãn cơ học lực thấp kéo dài chỉ khi có chỉ định và thiết bị phù hợp; theo dõi da, cảm giác, tưới máu và dừng khi bất thường. Thời lượng theo kế hoạch cụ thể, không tự kéo nhiều giờ.

4.2. Kéo dãn thụ động bằng dụng cụ cơ học có chu kỳ

Sử dụng dụng cụ cơ học tạo ra tầm vận động tự động thực hiện theo chu kỳ và điều chỉnh được cường độ, độ dài của từng chu kỳ và số chu kỳ kéo dãn trong một phút.

5. Thực hiện kỹ thuật tự kéo dãn

Là bài tập linh hoạt mà người bệnh tự thực hiện. Người bệnh kéo dãn một cách thụ động những cơ co rút của chính họ bằng cách sử dụng trọng lượng cơ thể như lực để kéo dãn.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Đánh giá đau, sưng, tầm vận động và chức năng ngay sau tập và lần tái khám; điều chỉnh theo đáp ứng.

Không mặc định phải đau ngày kế tiếp hoặc dùng thời gian đau cố định làm mục tiêu tập.

Chỉ tăng tải khi mô dung nạp và phù hợp chỉ định; dừng khi nghi tổn thương.

- Rách mô cơ, dây chằng, bao khớp hay trật khớp có thể xảy ra nếu kéo dãn khớp quá mức hay kỹ thuật kéo dãn không đúng, giật cục. Khớp sưng to hơn, đau kéo dài hơn có thể là những dấu hiệu xấu, cần điều chỉnh lại kỹ thuật chỉ điểm.

Nghi tổn thương: dừng, bảo vệ vùng tổn thương, đánh giá thần kinh mạch máu và báo bác sĩ. Chẩn đoán, bất động hoặc nhiệt trị liệu theo tổn thương; không áp cố định 21 ngày hay làm nóng thường quy.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

12 Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người

Mã đề xuất QT VLTL 12 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

1. Định nghĩa

- Liệt nửa người là liệt một tay, và một chân và nửa mặt cùng bên, có nhiều nguyên nhân nhưng thường gặp là do tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não…

- Kỹ thuật tập nằm đúng tư thế là kỹ thuật vị thế, người bệnh được đặt hoặc hướng dẫn nằm ở các tư thế đúng theo mẫu phục hồi

2. Sự cần thiết phải nằm đúng tư thế

- Để đề phòng và khắc phục co cứng bên liệt
- Kích thích người bệnh sử dụng bên liệt trong các động tác sinh hoạt hàng ngày
- Hạn chế các biến chứng do bất động

2 Chỉ định

- Các giai đoạn của liệt nửa người do tai biến mạch máu não; chấn thương sọ não; viêm não, màng não
- Phòng ngừa biến chứng và các thương tật thứ cấp như loét, nhiễm trùng hô hấp…
- Phòng ngừa co cứng trong giai đoạn đầu và ức chế co cứng khi co cứng đã xuất hiện của người bệnh liệt nửa người.

3 Chống chỉ định

Thận trọng khi người bệnh còn trong tình trạng cấp cứu.

4 Thận trọng

Bảo vệ vai liệt và điểm tỳ, đánh giá hô hấp, nuốt, đau, co cứng. Kê nâng đỡ, không ép góc vai cố định hoặc kéo tay khi xoay trở.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Gối và tấm kê giảm áp lực.

5.4 Trang thiết bị

Giường có khóa và nâng đỡ phù hợp.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án

- Ngày điều trị, giờ điều trị

- Kỹ thuật được chỉ định

- Tên kỹ thuật viên thực hiện y lệnh

2. Kiểm tra người bệnh

Tình trạng người bệnh trước khi tập

3. Thực hiện kỹ thuật

3.1. Người bệnh nằm nghiêng về phía bên liệt

- Đầu người bệnh được đỡ ngay ngắn và chắc chắn trên gối, không làm gấp các đốt sống cổ.

Nâng đỡ vai bên liệt, đặt bả vai phù hợp, tay trong tầm không đau; không ép góc cố định hoặc kéo tay để dịch chuyển thân.

- Chân bên liệt ở tư thế khớp háng duỗi, khớp gối hơi gấp.

- Thân mình ở tư thế nửa ngửa

- Tay bên lành đặt trên thân mình hoặc trên gối đỡ phía sau lưng.

- Chân bên lành được đỡ trên gối cao ngang mức với thân và hông, khớp háng và khớp gối gấp

3.2. Người bệnh nằm ngửa trên giường bệnh hoặc trên giường tập

- Đầu người bệnh được đỡ chắc chắn trên gối có chiều cao phù hợp để không làm gấp các đốt sống cổ, mặt nhìn thẳng hoặc quay về phía bên liệt.

Nâng đỡ tay bên liệt bằng gối, đặt vai và khuỷu theo tầm cho phép, tránh đau và kéo căng khớp vai.

- Dùng gối mỏng đỡ dưới hông bên liệt để đưa hông bên liệt ra trước, gối đỡ dưới khoeo để gấp khớp háng và khớp gối bên liệt, gối hoặc túi cát đỡ phía mắt cá ngoài để chân bên liệt không bị đổ ra ngoài.

- Tay và chân bên lành ở vị trí mà người bệnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

3.3. Người bệnh nằm nghiêng về phía bên lành

- Đầu người bệnh được đỡ ngay ngắn và chắc chắn trên gối, không làm gấp các đốt sống cổ.

- Tay bên liệt được đỡ bằng gối ở phía trước, cao ngang bằng mức với thân mình với khớp vai và khớp khuỷu duỗi.

- Thân mình vuông góc với mặt giường, có gối đỡ phía lưng.

- Chân bên liệt được đỡ trên gối ở phía trước cao ngang mức với thân mình, khớp háng và khớp gối gấp.

- Chân và tay bên lành ở vị trí mà người bệnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu

Thay đổi tư thế theo kế hoạch cá thể hóa dựa trên nguy cơ tỳ đè, da và dung nạp; ghi thời điểm và kiểm tra điểm tỳ.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi tập
- Theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường
- Nếu có bất thường xử trí kịp thời theo đúng phác đồ, báo cáo bác sĩ
- Ghi chép hồ sơ bệnh án: Tình trạng người bệnh trong và sau khi tập

Hướng dẫn người bệnh đề phòng những tai biến có thể xảy ra như: Đau, khó chịu, mệt mỏi… nếu thấy có gì bất thường báo cáo bác sĩ ngay.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

Tài liệu đối chiếu

1. NICE NG236 Stroke rehabilitation in adults, mục vận động và đau vai; nguồn đối chiếu chuyên môn quốc tế. Nguồn đối chiếu

13 Tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người

Mã đề xuất QT VLTL 13 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

1. Định nghĩa

- Liệt nửa người là liệt một tay, và một chân và nửa mặt cùng bên, nguyên nhân có nhiều nhưng thường gặp nhất là tai biến mạch máu não thường do tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não là dấu hiệu phát triển nhanh trên lâm sàng của một rối loạn khu trú chức năng của não kéo dài trên 24 giờ và thường do nguyên nhân mạch máu..

2. Tầm quan trọng của tập tay và bàn tay

- Tay và bàn tay liệt thường bị giảm và mất chức năng nặng và khó hồi phục hơn chân do mức độ vận động tinh tế của tay và bàn tay.
- Phục hồi chức năng tay và bàn tay liệt giúp người bệnh phục hồi được khả năng độc lập trong sinh hoạt hàng ngày
- Do bàn tay có hoạt động rất tinh tế do đó cần có kỹ thuật tập phục hồi chức năng riêng

2 Chỉ định

- Tất cả các giai đoạn của liệt nửa người do tai biến mạch máu não
- Có thể áp dụng cho người bệnh liệt nửa người do chấn thương sọ não; viêm não, màng não, u não…

3 Chống chỉ định

Thận trọng khi người bệnh còn trong tình trạng cấp cứu và trong giai đoạn liệt mềm.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Vật cầm nắm an toàn nhiều cỡ.

5.4 Trang thiết bị

Bàn ghế vừa tầm và dụng cụ hoạt động trị liệu.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Lượng giá đau vai, tầm, sức cơ, trương lực, cảm giác và chức năng; thống nhất mục tiêu.

Bước 2. Đặt tư thế ổn định, nâng đỡ tay yếu và kiểm soát bả vai.

Bước 3. Tập thụ động hoặc trợ giúp trong tầm an toàn; chuyển chủ động khi đủ khả năng.

Bước 4. Tập với, nắm, di chuyển và thả vật an toàn; chọn kích thước, tải theo chức năng.

Bước 5. Tập hai tay và hoạt động sinh hoạt phù hợp, tăng khó theo đáp ứng; không kéo vai hoặc ép qua đau.

Bước 6. Đánh giá lại, hướng dẫn bài tại nhà đã kiểm tra thực hiện đúng; ghi kết quả và kế hoạch.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi tập
- Theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường
- Nếu có bất thường xử trí kịp thời theo đúng phác đồ, báo cáo bác sĩ
- Ghi chép hồ sơ bệnh án: Tình trạng người bệnh trong và sau khi tập

Hướng dẫn người bệnh đề phòng những tai biến có thể xảy ra như: Đau tăng lên, khó chịu, mệt mỏi… nếu thấy có gì bất thường báo cáo bác sĩ ngay.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

Tài liệu đối chiếu

1. NICE NG236 Stroke rehabilitation in adults, mục vận động và đau vai; nguồn đối chiếu chuyên môn quốc tế. Nguồn đối chiếu

14 Tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người

Mã đề xuất QT VLTL 14 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

1. Định nghĩa

Liệt nửa người là liệt một tay, và một chân và nửa mặt cùng bên, thường do tai biến mạch máu não.

2. Tầm quan trọng của tập đứng và đi

- Tập đứng và đi giúp người bệnh có thể tự di chuyển được
- Dự phòng được các biến chứng của bất động
- Giúp người bệnh phục hồi khả năng tự phục vụ và hòa nhập với gia đình và xã hội

2 Chỉ định

- Giai đoạn sau của liệt nửa người do tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, sau mổ u não, sau viêm não….
- Khi người bệnh đã có thể tự ngồi và kiểm soát được thăng bằng.
- Tình trạng tim mạch và toàn thân cho phép

- Có thể áp dụng đối với các người bệnh chấn thương sọ não; viêm não, màng não, u não…có liệt nửa người.

3 Chống chỉ định

Thận trọng với người bệnh liệt mềm; người bệnh có rối loạn thăng bằng.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày, đai, nẹp theo chỉ định.

5.4 Trang thiết bị

Thanh song song, tay vịn, dụng cụ trợ đi.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án

- Chỉ định của Bác sỹ

- Tên kỹ thuật viên thực hiện tập luyện

2. Kiểm tra người bệnh

- Tình trạng toàn thân, tim mạch, hô hấp của người bệnh trước khi tập

- Giải thích để người bệnh phối hợp

3. Thực hiện kỹ thuật

3.1. Quy trình kỹ thuật tập đứng

- Người bệnh ngồi trên ghế có chiều cao phù hợp, đầu và thân mình thẳng, hai vai cân xứng, trọng lượng cơ thể dồn đều lên hai bên mông và hai chân.

- Người hướng dẫn Kỹ thuật viên đứng phía trước hoặc phía bên liệt của người bệnh.

- Giúp hoặc hướng dẫn người bệnh dồn trọng lượng về phía trước để đứng lên

- Hướng dẫn người bệnh tự đứng lên không cần trợ giúp

- Thực hiện các bài tập ở tư thế đứng như:

+ Đứng thăng bằng tĩnh và động,

+ Tập dồn trọng lượng lên chân liệt,

+ Tập chuyển và dồn trọng lượng lần lượt lên hai chân,

+ Tập chủ động gấp, duỗi chân liệt,

+ Tập luân phiên gấp riêng khớp gối từng bên,

+ Tập kiểm soát vận động của khớp gối bên liệt,

+ Tập làm giảm co cứng duỗi ở khớp cổ chân

3.2. Quy trình kỹ thuật tập đi

- Tập đứng dồn trọng lượng lên chân lành, bước chân liệt lên phía trước và ra phía sau

- Tập tăng cường thăng bằng và kiểm soát vận động của khớp háng, chân bên liệt.

- Tập luyện dáng đi

- Tập bước tại chỗ trên bàn chạy,

- Tập đi

- Tập lên, xuống dốc; tập lên xuống cầu thang: lên cầu thang bước chân lành lên trước rồi đưa chân liệt lên cùng bậc, khi xuống cầu thang bước chân lành xuống bậc thang đầu tiên rồi đưa chân lành xuống cùng bậc.

- Tập đi trên các bề mặt không bằng phẳng và các địa hình khác nhau:

Thời gian đầu tập trong thanh song song, sau đó tập trong khung tập đi rồi mới tập với nạng.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Đánh giá tình trạng người bệnh sau khi tập

- Theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường

- Nếu có bất thường xử trí kịp thời theo đúng phác đồ, báo cáo bác sĩ

- Ghi chép hồ sơ bệnh án: Tình trạng người bệnh trong và sau khi tập

Hướng dẫn người bệnh đề phòng những tai biến có thể ngã trong khi tập

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

Tài liệu đối chiếu

1. NICE NG236 Stroke rehabilitation in adults, mục vận động và đau vai; nguồn đối chiếu chuyên môn quốc tế. Nguồn đối chiếu

15 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi

Mã đề xuất QT VLTL 15 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

- Thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi là các vận động cần thiết cho các chức năng di chuyển thường nhật thông thường mà người bệnh cần tự thực hiện hay thực hiện có trợ giúp bằng dụng cụ hay bằng trợ giúp của người điều trị.

- Tư thế ngồi là một trong những tư thế thoải mái, tự nhiên, vững vàng và được dùng nhiều nhất trong đời sống hàng ngày.

2 Chỉ định

- Được dùng tập cho các người bệnh nằm lâu tại giường

- Chuẩn bị cho tiến trình tập tiếp theo như đứng dậy từ vị thế ngồi hay di chuyển từ giường qua ghế và xe lăn

- Dùng trong trường hợp người bệnh cần được ngồi để cố định xương chậu, tập cột sống nhất là cử động xoay trong vị thế ngồi.

- Dùng trong trường hợp người bệnh cần được ngồi để tập cử động cẳng bàn chân trong trạng thái không chịu trọng lượng của cơ thể.

- Dùng trong trường hợp người bệnh cần được ngồi để rèn luyện tư thế đúng cho phần trên của cơ thể.

3 Chống chỉ định

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

- Người bệnh có gãy xẹp thân đốt sống, gãy xương chậu mới can xương chưa chắc (độ 1, độ 2).

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày và đai khi phù hợp.

5.4 Trang thiết bị

Giường có khóa, tay vịn, ghế vững.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ

Lựa chọn bài tập và kỹ thuật phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh để có thể đạt được mục đích tốt nhất.

2. Kiểm tra và chuẩn bị người bệnh

- Giải thích mục đích bài tập và quy trình tập cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe tổng quát, huyết áp của người bệnh để chắc chắn người bệnh không chóng mặt hay tụt huyết áp khi ngồi dậy

- Dùng các kỹ thuật thư giãn trước khi tập ngồi dậy nếu người người bệnh co cứng cơ ở các chi hay thân mình.

3. Thực hiện bài tập

- Ngồi dậy từ vị thế nằm nghiêng một bên (thường dùng cho người bệnh liệt bán thân): Người bệnh nằm nghiêng một bên sát mép giường, tay trên dọc trên thân, người điều trị giúp người bệnh đưa hai chân ra khỏi mép, hướng dẫn người bệnh nâng đầu, vai lên, chống tay dưới đẩy nâng thân mình lên để ngồi dậy.

- Tự ngồi dậy từ vị thế nằm ngửa (thường dùng cho người bệnh liệt hai chi dưới hay người bệnh nằm lâu trên giường): Nằm ngửa, hai tay dọc thân mình, nâng đầu dậy hoặc nâng hai vai bằng cách tỳ trên hai khuỷu tay, chịu sức nặng trên bàn tay, duỗi cánh tay và cẳng tay. Từ từ nâng thân mình luân phiên hay đồng thời lùi hai bàn tay về phía sau để ngồi dậy hoàn toàn, sau đó đưa hai tay về phái trước đặt lên đùi để giữ vững vị thế ngồi

Hỗ trợ thân và khung chậu để chuyển ngồi; dùng tay còn chức năng hoặc tay vịn phù hợp, không níu kéo tay bên liệt.

- Ngồi dậy một bên từ vị thế nằm sấp (dùng cho trẻ em chậm phát triển vận động, trẻ bại não): Nằm sấp, nâng đầu dậy bằng cách duỗi cổ, đặt một hoặc hai bàn tay trên nệm hoặc sàn nhà ngay phía dưới khớp vai, chống tay duỗi khuỷu để đẩy thân đồng thời xoay thân, đẩy người vào vị thế ngồi một bên. Nếu dùng một tay để đẩy, người bệnh xoay và ngồi về phía tay đó.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Theo dõi người bệnh về chỉ số mạch an toàn, huyết áp trước và sau khi tập để đảm bảo an toàn cho người bệnh nhất là những người bệnh nằm lâu tại giường trước đó.

- Nếu người bệnh mệt nhiều giảm cường độ tập.

- Nếu người bệnh có thể tự ngồi dậy từ vị thế nằm vững và an toàn, đúng mẫu, có thể chuyển sang giai đoạn tập ngồi thăng bằng tĩnh và động.

Tụt huyết áp tư thế, chóng mặt. Cách dự phòng có thể nâng đầu giường từ từ tăng dần để tránh hạ huyết áp tư thế đối với người bệnh nằm lâu tại giường trước khi tập cho người bệnh ngồi dậy

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

16 Tập thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng

Mã đề xuất QT VLTL 16 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

- Thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng là các vận động cần thiết chuẩn bị cho tập đứng và đi mà người bệnh cần tự thực hiện hay thực hiện có trợ giúp bằng dụng cụ hay bằng trợ giúp của người điều trị.

- Tư thế đứng được dùng trong nhiều phương thức tập luyện nhưng chỉ thích hợp nếu duy trì được đúng vì trạng thái cân bằng cơ thể kém ổn định hơn các tư thế khác.

2 Chỉ định

- Người bệnh liệt nửa người do tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, u não, viêm não...
- Người bệnh liệt hai chân do tổn thương tủy sống do tai nạn giao thông, viêm tủy cắt ngang, đa u tủy, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống tủy...
- Người bệnh bị các bệnh lý thần kinh như Parkinson, viêm đa dây đa rễ thần kinh, đa xơ cứng, xơ cứng cột bên teo cơ...
- Người bệnh bị bại não, chậm phát triển vận động tinh thần
- Người bệnh yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới...
- Người bệnh sau phẫu thuật thay khớp toàn phần hay bán phần các khớp háng, gối...
- Người bệnh đoạn chi, lắp chân giả các loại.

3 Chống chỉ định

Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày chống trượt và đai khi cần.

5.4 Trang thiết bị

Ghế có tay vịn, giường và khung theo chỉ định.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ

Lựa chọn bài tập và kỹ thuật phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh để có thể đạt được mục đích tốt nhất.

2. Kiểm tra và chuẩn bị người bệnh

- Giải thích mục đích bài tập và quy trình tập cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe tổng quát, huyết áp của người bệnh để chắc chắn người bệnh không chóng mặt hay tụt huyết áp khi đứng dậy nhất là những người bệnh nằm dài ngày trên giường

- Dùng các kỹ thuật thư giãn trước khi tập đứng dậy nếu người bệnh co co cứng cơ ở các chi hay thân mình.

3. Thực hiện bài tập

- Tư thế người bệnh: Người bệnh ngồi trên giường hoặc trên ghế, hai bàn chân đặt sát trên sàn nhà, ngang nhau và ở sau hai gối một chút.

Hỗ trợ thân và khung chậu hoặc đai phù hợp; không kéo tay hoặc nhấc bằng nách.

- Người điều trị ngồi một bên của người bệnh, dùng một tay giúp người bệnh đưa hai tay về phía trước, một tay giữ gối bên liệt ấn xuống về phía sàn nhà, yêu cầu người bệnh cúi người về trước, hai vai ra trước hai gối, lưng duỗi, cổ duỗi, chuyển trọng lượng từ mông sang hai chân và đứng dậy.

Đẩy tay lên tay vịn ghế hoặc mặt giường để đứng, giữ thăng bằng rồi mới cầm khung; không kéo khung để đứng lên.

- Tập đứng dậy trong thanh song song với hai nẹp chân khóa gối trong trường hợp liệt hai chi dưới có mang nẹp: Đưa xe lăn vào thanh song song, khóa gối hai nẹp, khóa xe lăn, hai chân người bệnh duỗi thẳng về phía trước, hai gót chân tiếp xúc với nền nhà. Gập thân mình về trước, nắm hai tay trên hai thanh song song, kéo hai cánh tay và nâng thân mình lên, đưa hông về phía trước. Người điều trị đứng phía

trước người bệnh giữ hai chân không cho người bệnh trượt. Có thể dùng một đai ngang thắt lưng để kéo hỗ trợ người bệnh đứng dậy.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Kiểm tra tình trạng huyết áp, chỉ số mạch an toàn đối với những người bệnh nằm lâu trước đó. Nếu người bệnh chóng mặt, mệt thì nên ngừng tập và để người bệnh nằm nghỉ.

- Khi người bệnh có thể chuyển vị thế từ ngồi sang đứng an toàn, đúng mẫu, có thể chuyển sang giai đoạn tập thăng bằng đứng tĩnh và động.

Người bệnh có thể bị ngã khi cố gắng chuyển trọng lượng từ mông sang chân để đứng dậy, đặc biệt ở những người bệnh tai biến mạch não, chấn thương sọ não hay liệt hai chân do tổn thương tủy. Người điều trị cần đứng gần người bệnh ở phía trước hay bên liệt để hỗ trợ người bệnh kịp thời khi cần.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

17 Tập dáng đi

Mã đề xuất QT VLTL 17 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

1. Định nghĩa

- Đi (với nhiều hình thức khác nhau của nó: đi bộ, chạy, lên xuống cầu thang…) là một hoạt động điều hợp khéo léo và thăng bằng mà chúng ta đạt được trong quá trình phát triển từ nhỏ và có thể tập luyện để cải thiện. Đây là một hoạt động liên quan đến nhiều khớp và cơ nhưng được thực hiện mà không có bất kỳ một sự cố gắng có ý thức nào cho tới khi một trong những thành phần cơ hay khớp đó bị mất điều khiển.

- Khi đi, chúng ta di chuyển các thành phần cơ thể theo một trật tự nhất định thích nghi với loại mặt phẳng mà ta đi trên nó, với không gian và với những bất trắc bao quanh chúng ta. Tất cả các đường vào cảm giác đều liên quan đến hoạt động đi và khi có bất cứ phần nào trong hệ thống cảm giác bị mất kiểm soát, dáng đi cũng có thể bị ảnh hưởng.

2. Chu kỳ đi: Một chu kỳ đi hoàn chỉnh bao gồm các giai đoạn sau:

- Thì chạm gót (chiếm 0-15% chu kỳ đi): Sức nặng cơ thể được truyền qua chân trước, bàn chân hạ xuống mặt đất bằng chạm gót.

- Giữa thì chống (từ 15%-30% chu kỳ đi): Trọng lượng cơ thể đặt trên bàn chân, thân mình và chân tiến về phía trước trên bàn chân đứng yên.

- Thì đẩy (từ 30-45% chu kỳ đi): Gót chân của chân chịu sức nặng rời khỏi mặt đất, thân mình đẩy về phía trước bởi tác động của cơ gấp lòng bàn chân.

- Cuối thì chống: (từ 45-60% chu kỳ đi): Khối lượng cơ thể được chuyển hoàn toàn sang chân đối bên để ngón chân nhấc lên khỏi sàn nhà

- Thì đu đưa (chiếm 40% cuối cùng của chu kỳ đi): Bắt đầu từ giai đoạn gia tốc đến giữa thì đu đưa khi chân đu băng qua chân chống bên kia và cuối cùng là giai đoạn giảm tốc.

- Cuối giai đoạn chống của chân này và đầu giai đoạn chống của chân kia có một thời gian cơ thể chịu sức nặng trên hai chân gọi là giai đoạn chống kép, giai đoạn này càng ngắn khi tốc độ đi càng nhanh và không còn nữa khi chạy.

3. Các nhóm cơ tham gia vào hoạt động đi

- Các cơ đẩy là các cơ gập ngón chân, cơ gập mặt lòng bàn chân, cơ duỗi gối và háng.

- Các cơ đu qua là các cơ duỗi của ngón chân, cơ gập mặt lưng bàn chân, cơ gập và duỗi gối, và cơ gập háng.

- Các cơ dạng, xoay trong, xoay ngoài khớp háng, gập bên và xoay thân cũng hoạt động trong giai đoạn chuyển trọng lượng và cử động chậu. Nếu không có cử động thăng bằng của chậu trong cả hai cử động kéo và xoay khớp háng, không thể có dáng đi đúng được.

- Các cơ xoay của thân trên và đầu cũng hoạt động, do vậy mặt và phần thân trên duy trì hướng về phía trước. Tầm độ hoạt động của mỗi nhóm cơ này tùy thuộc trên độ dài và chiều cao của bước chân.

- Cần phải duy trì sức mạnh của những nhóm cơ liên quan để chúng hoạt động hiệu quả khi đi, đặc biệt là những nhóm cơ chịu sức nặng của chi. Những nhóm cơ phụ của thân cũng phải được tập mạnh và cũng không được quên sự đu đưa bình thường của cánh tay khi đi.

2 Chỉ định

- Người bệnh liệt nửa người do tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, u não, viêm não...

- Người bệnh liệt hai chân do tổn thương tủy sống do tai nạn, viêm tủy cắt ngang, u tủy, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống tủy...

- Người bệnh bị các bệnh lý thần kinh như Parkinson, viêm đa dây đa rễ thần kinh, xơ cứng rải rác, xơ cứng cột bên teo cơ...

- Người bệnh bị bại não, chậm phát triển vận động tinh thần

- Người bệnh yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới...

- Người bệnh sau phẫu thuật thay khớp toàn phần hay bán phần các khớp háng, gối...

- Người bệnh đoạn chi, lắp chân giả các loại.

3 Chống chỉ định

Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày, nẹp theo chỉ định.

5.4 Trang thiết bị

Lối tập phẳng, gương, tay vịn hoặc dụng cụ trợ đi.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ, lựa chọn kỹ thuật

Lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh.

2. Kiểm tra và chuẩn bị người bệnh

Giải thích mục đích bài tập và quy trình tập cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn

3. Thực hiện kỹ thuật

3.1. Những bài tập duy trì hay gia tăng lực cơ trên giường

Tất cả các bài tập này nên có đề kháng bằng lò xo hay tạ khi có thể và không chống chỉ định, nên được tập trong suốt thời gian nằm viện.

Đối với tay: Gập các ngón, đối ngón cái, duỗi cổ tay, duỗi khuỷu, duỗi vai, xoay trong vai, hạ vai

Đối với thân: Xoay, duỗi, gập thân, gập bên chậu và kéo khớp háng

Đối với chân: Gập và duỗi các ngón và bàn chân, gập và duỗi gối, gập và duỗi háng, dang và khép háng, xoay trong và xoay ngoài khớp háng.

Những bài tập tăng tiến: Nếu người bệnh nằm lâu, khi chuẩn bị tập đi cần:

- Cần thời gian để thích nghi với tư thế thẳng đứng.

- Cần được hướng dẫn co cơ thành bụng, thở sâu để đảm bảo tuần hoàn tĩnh mạch sâu và cung cấp máu đầy đủ cho não trước khi ngồi thẳng dậy.

- Cần tập bài tập thăng bằng trong tư thế nửa nằm, ngồi trên giường, ngồi trên ghế cao, ngồi trên xe lăn với chân đặt trên sàn nhà hay trên dụng cụ nâng đỡ nếu người bệnh được dự đoán có phản ứng thăng bằng kém.

- Bàn nghiêng quay rất có giá trị cho những người bệnh cần được hướng dẫn lại cách chịu sức nặng sau chấn thương chi dưới. Bàn nghiêng quay được nghiêng dần từ vị thế nằm ngang sang vị thế đứng thẳng sao cho người bệnh có thể gia tăng dần chịu sức nặng trên phần bị thương.

3.2 Các bài tập luyện dáng đi

* Bài tập với chân phải lên trước, chân trái chống chịu sức nặng

Bài tập thì chạm gót (chân phải): Tập đầu và thân thẳng, tay thả lỏng giữa thân mình. Khung chậu xoay về phía trước một ít, gối phải duỗi, bàn chân phải gập mặt lưng và thẳng góc với cẳng chân.

Bài tập giữa thì chống (chân phải):

Tập đầu và thân thẳng đứng, hai tay gần đường giữa thân, khuỷu hơi gập. Khung chậu nghiêng bên trái một ít, chân phải xoay ngoài nhẹ khớp háng.

Bài tập thì đẩy tới (chân phải):

Tay phải ở trước đường giữa thân với khuỷu gập nhẹ, tay trái ở sau với khuỷu duỗi. Khung chậu xoay trước, gối phải gập nhẹ, cổ chân phải gập mặt lòng, các ngón chân phải duỗi quá ở bàn đốt.

Bài tập giữa thì đu (chân phải):

Khung chậu xoay trước ít, hai tay giữa thân mình. Hông và gối phải gập, bàn chân thẳng góc với cẳng chân và hơi nghiêng ngoài.

Bài tập thì chống kép:

Điều chỉnh độ dài và nhịp bước theo chức năng, chiều cao và thăng bằng; không áp một độ dài bước cho mọi người.

* Lặp lại như trên với chân trái lên trước, chân phải chống chịu sức nặng.

Chọn kiểu bước theo chịu tải và thăng bằng; bài đu người hoặc bài khó chỉ khi đủ khả năng và có bảo vệ.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Người bệnh cảm thấy thoải mái, vững vàng khi di chuyển trọng lượng cơ thể, không có các cử động thay thế như nâng chậu thay thế gập hông, quét vòng chân thay thế gập gối trong thì đu đưa hay duỗi quá gối (khóa gối) trong thì chống, nâng hông một bên thay thế mất gập mặt lưng bàn chân ở cuối thì chống.
- Khi người bệnh đã có thực hiện dáng đi tốt với các thì chống và đu đưa hợp lý, đúng mẫu, chuyển tiếp sang giai đoạn tập đi với hai tay cử động phối hợp bên thân và tập tăng dần tốc độ đi cho tới khi đạt được tốc độ đi bình thường.

Người bệnh có thể té ngã nếu người bệnh không đủ thăng bằng khi đứng hoặc khi đi. Trong trường hợp này cho người bệnh tập dáng đi trong thanh song song trước khi tập ngoài thanh song song. Người điều trị luôn đứng một bên hoặc phía trước người bệnh để có thể trợ giúp kịp thời khi cần.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

18 Tập đi trong thanh song song

Mã đề xuất QT VLTL 18 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Tập đi trong thanh song song thường được sử dụng trong giai đoạn đầu của quá trình tập đi cho người bệnh sau khi người bệnh đã tự đứng được, thăng bằng đứng tương đối tốt.

2 Chỉ định

- Người bệnh liệt nửa người do tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, u não, viêm não...
- Người bệnh liệt hai chân do tổn thương tủy sống do tai nạn, viêm tủy cắt ngang, u tủy, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống tủy...
- Người bệnh bị các bệnh lý thần kinh như Parkinson, viêm đa dây đa rễ thần kinh, xơ cứng rải rác, xơ cứng cột bên teo cơ...
- Người bệnh bị bại não, chậm phát triển vận động tinh thần
- Người bệnh yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới...
- Người bệnh sau phẫu thuật thay khớp toàn phần hay bán phần các khớp háng, gối...
- Người bệnh đoạn chi, lắp chân giả các loại.

3 Chống chỉ định

Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày, đai và nẹp.

5.4 Trang thiết bị

Thanh song song chắc, đúng chiều cao.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ, lựa chọn kỹ thuật

Lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh.

2. Kiểm tra và chuẩn bị người bệnh

Giải thích mục đích bài tập và quy trình tập cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

3. Thực hiện kỹ thuật

3.1. Tập đứng dậy

- Tốt nhất cho người bệnh tập luyện ở thanh song song có bước chân. Xe lăn được đặt giữa hai thanh song song, khóa lại và người bệnh di chuyển tới phía trước của xe, nâng chỗ đặt bàn chân của xe lên, hai tay người bệnh đặt trên hai bên thanh song song và kéo người đứng dậy (nếu người bệnh có thể làm như vậy).

- Với người bệnh có thể chịu sức nặng trên cả hai chân mà không có chống chỉ định, có thể tập đứng dậy bằng hai phương pháp mà sự chọn lựa tùy thuộc vào:

+ Chiều cao của người bệnh và người điều trị.

+ Sự vạm vỡ của người bệnh.

+ Chiều dài của cánh tay người điều trị.

+ Khả năng thăng bằng của người bệnh.

Phương pháp 1:

Đỡ thân, khung chậu hoặc đai phù hợp, không nhấc người bằng nách.

Phương pháp 2:

Đứng bảo vệ và hỗ trợ thân, khung chậu khi cần; không kéo nách hoặc vai bên liệt.

3.2. Tập thăng bằng trong thanh song song

- Người bệnh được luyện tập thăng bằng bằng sử dụng kỹ thuật ổn định nhịp nhàng với một lực ép trên khớp vai hoặc trên chậu hoặc trên cả hai. Khuyến khích người bệnh thực hiện gập và duỗi của chân đứng trong tầm độ nhỏ, di chuyển tay ra trước và sau trên thanh song song.

- Nếu người bệnh có thể chịu trọng lượng trên cả hai chân, tập di chuyển trọng lượng sang hai bên trong vị thế đứng dang chân sang hai bên trước, sau đó di chuyển trọng lượng trước sau trong vị thế đứng chân trước chân sau.

- Lực ép của người điều trị trên chậu bên hướng người bệnh đưa qua sẽ khuyến khích người bệnh đẩy chậu về hướng trên chân đế do vậy có thể chuyển trọng lượng sang chân đế. Người bệnh cần có thời gian nghỉ theo yêu cầu.

3.3. Tập đi trong thanh song song

- Người bệnh được tập đi trong thanh song song tăng tiến khởi đầu với dáng đi đu tới bằng cách di chuyển hai bàn tay về phía trước, nhún thân mình đặt hai chân tới cùng mức với đoạn tiến của tay

- Tập dáng đi đu qua bằng di chuyển hai bàn tay về phía trước, nhún thân mình đặt hai chân tới quá mức với đoạn tiến của tay (xa hơn tay)

- Tập dáng đi bốn điểm: đưa tay phải lên trước, tiếp đến chân trái lên, tiếp đến tay trái và cuối cùng là chân phải lên

- Tập đi hai điểm: tay phải và chân trái đồng thời đưa lên phái trước, sau đó tay trái và chân phải tiến lên đồng thời.

Người bệnh cũng có thể sử dụng một thanh song song và một nạng, sau đó cả hai nạng nếu thanh song song đủ rộng. Người điều trị cần đi cạnh người bệnh.

Khoảng cách đi nên được xem xét và để người bệnh được nghỉ thường xuyên nếu người bệnh sợ hãi hay yếu. Khi người bệnh mạnh hơn, thực hiện tốt hơn thì nên tăng dần khoảng cách đi và giảm dần thời gian, số lần nghỉ.

Khi thanh song song quá dài thì cần đưa xe lăn hay ghế vào giúp người bệnh ở bất cứ khoảng nào trong thanh song song để người bệnh nghỉ khi có nhu cầu.

3.4. Tập xoay người trong thanh song song

- Bàn chân được đặt qua một bên với góc 45o, cánh tay gần cùng bên di chuyển trên thanh mà người bệnh xoay người đối mặt với nó, một loạt bước chân bước qua được thực hiện tiếp để xoay tới 90o và di chuyển cánh tay phía sau người bệnh theo hướng xoay, một lần bước nữa sẽ hoàn chỉnh sự xoay người.

Chọn kiểu bước theo chịu tải và thăng bằng; bài đu người hoặc bài khó chỉ khi đủ khả năng và có bảo vệ.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Người bệnh thấy thoải mái và vững vàng trong thanh song song. Cần kiểm soát dáng đi của người bệnh tốt để đảm bảo không có những cử động thay thế.

- Có thể sử dụng hai tay trợ giúp khi di chuyển trong thanh song song để đảm bảo thăng bằng và an toàn cho người bệnh.

Nếu người bệnh chưa thăng bằng đứng tĩnh và động tốt, người bệnh có thể bị ngã.

Hướng dẫn người bệnh di chuyển tay trên thanh song song để trợ giúp thăng bằng.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

19 Tập đi với khung tập đi

Mã đề xuất QT VLTL 19 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Khung tập đi là một loại dụng cụ trợ giúp di chuyển cần thiết để giúp người gặp khó khăn trong di chuyển đi lại. Có nhiều loại khung tập đi khác nhau: có bánh xe, không có bánh xe…

2 Chỉ định

Người bệnh liệt nửa người, liệt hai chi dưới, người bệnh tập sử dụng chân giả, nẹp chỉnh hình, trẻ bại não, bại liệt, một số bệnh lý chi dưới khác…

3 Chống chỉ định

Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4 Thận trọng

Chọn khung theo thăng bằng, lực tay và tải trọng; kiểm tra đầu cao su, bánh và phanh. Đẩy tay từ ghế để đứng, đứng vững mới cầm khung.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày, đai hoặc nẹp.

5.4 Trang thiết bị

Khung đúng loại và chiều cao, ghế tay vịn.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Xác nhận mức chịu tải, thăng bằng và loại khung; điều chỉnh, kiểm tra và dọn lối tập.

Bước 2. Đẩy tay từ tay vịn ghế để đứng, người hướng dẫn bảo vệ thân và khung chậu; đứng vững mới cầm khung.

Bước 3. Đưa khung đoạn ngắn và đặt vững; khung bánh xe điều khiển theo đúng loại.

Bước 4. Đưa chân yếu hoặc có giới hạn tải vào khoảng khung theo kế hoạch, sau đó chân còn lại; tay chịu phần tải chỉ định, không bước quá xa trước khung.

Bước 5. Quay bằng bước nhỏ. Khi ngồi, lùi đến ghế, với tay tới tay vịn rồi hạ có kiểm soát; không kéo khung.

Bước 6. Nghỉ và đánh giá, ghi quãng đường, trợ giúp, loại khung và đáp ứng.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi tình trạng, mạch, nhiệt độ, huyết áp của người bệnh trong và sau khi làm kỹ thuật.

- Trong khi tập với khung tập đi người bệnh có thể bị ngã hoặc dụng cụ bị gãy.

- Xử trí: kiểm tra kỹ dụng cụ trước khi tập, phải luôn có một người đi cạnh để trợ giúp người bệnh

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

20 Tập lên xuống cầu thang

Mã đề xuất QT VLTL 20 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Tập lên xuống cầu thang là một bài tập chức năng quan trọng, giúp cải thiện và nâng cao chức năng đi lại của người bệnh. Bài tập này đặc biệt có ích cho những người bệnh có khó khăn trong di chuyển, những người bệnh yếu hoặc liệt. Tập lên xuống cầu thang có thể kết hợp với các dụng cụ trợ giúp (ví dụ: nạng, gậy...).

2 Chỉ định

- Người bệnh liệt nửa người

- Người bệnh yếu hai chân

- Người bệnh khó khăn trong di chuyển như đau thần kinh tọa, đau một chân, gãy xương chi dưới.

3 Chống chỉ định

- Thể trạng quá yếu, đứng chưa vững

- Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4 Thận trọng

Đủ kiểm soát tư thế và chịu tải mới tập. Có tay vịn và người bảo vệ; hai chân yếu hoặc dùng nạng cần kế hoạch riêng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày, nẹp và dụng cụ theo chỉ định.

5.4 Trang thiết bị

Cầu thang tập có tay vịn, chống trượt, ghế nghỉ.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Tập lên xuống cầu thang (Áp dụng cho người bệnh đau một chân, đau thần kinh tọa, khó khăn khi di chuyển…)

Tư thế người bệnh ban đầu: ngồi trên ghế

1.1. Lên cầu thang

- Kỹ thuật viên đứng phía sau người bệnh

- Kỹ thuật viên hướng dẫn người bệnh chuyển từ ngồi sang đứng

Tập từng bậc: lên đưa chân khỏe trước, sau đó chân yếu và dụng cụ; xuống đưa dụng cụ và chân yếu trước, rồi chân khỏe theo hướng dẫn. Hai chân yếu cần kế hoạch riêng.

- Người bệnh tiếp tục thực hiện lên các bậc tiếp theo

1.2. Xuống cầu thang

- Kỹ thuật viên đứng phía trước người bệnh
- Người bệnh bám tay lành vào thành cầu thang đồng thời bước chân đau xuống trước, sau đó đến chân lành bước xuống cùng bậc
- Người bệnh tiếp tục thực hiện xuống các bậc tiếp theo
- Người bệnh xoay người ngồi vào ghế
- Dặn dò người bệnh, thu dọn dụng cụ

2. Tập lên xuống cầu thang cho người bệnh liệt nửa người

2.1. Lên cầu thang

- Kỹ thuật viên đứng phía sau người bệnh
- Kỹ thuật viên hướng dẫn người bệnh chuyển từ ngồi sang đứng
- Người bệnh bám tay lành vào thành cầu thang đồng thời bước chân lành lên trước, sau đó đến chân liệt bước lên cùng bậc chân lành
- Người bệnh tiếp tục thực hiện lên các bậc tiếp theo

2.2. Xuống cầu thang

- Kỹ thuật viên đứng phía trước người bệnh
- Người bệnh bám tay lành vào thành cầu thang đồng thời bước chân liệt xuống trước, sau đó đến chân lành bước xuống cùng bậc chân liệt
- Người bệnh tiếp tục thực hiện xuống các bậc tiếp theo
- Người bệnh xoay người ngồi vào ghế
- Dặn dò người bệnh, thu dọn dụng cụ

3. Tập lên xuống cầu thang với nạng cho người bệnh yếu hai chân

3.1. Lên cầu thang

- Kỹ thuật viên đứng phía dưới người bệnh
- Hướng dẫn người bệnh chuyển từ ngồi sang đứng (2 nạng đặt phía trước)
- Nếu người bệnh thăng bằng đứng tốt - Kỹ thuật viên chuyển nạng sang hai bên
- Di chuyển với nạng bằng cách đi đu đưa đến gần cầu thang
- Người bệnh sử dụng hai nạng như một. Một tay chống nạng, một tay chống ở lan can
- Đu chân lên trước rồi đến hai nạng lên cùng bậc với hai chân
- Người bệnh đi tiếp lên các bậc thang

3.2. Xuống cầu thang

- Kỹ thuật viên đứng phía trước người bệnh
- Người bệnh sử dụng hai nạng như một. Một tay chống nạng, một tay chống ở lan can
- Đưa nạng xuống trước rồi đu hai chân xuống sau cùng bậc với nạng
- Người bệnh đi tiếp xuống cầu thang
- Đi đu đưa đến gần ghế và ngồi xuống
- Người bệnh làm kỹ thuật viên sửa sai.
- Dặn dò người bệnh, thu dọn dụng cụ

Chọn kiểu bước theo chịu tải và thăng bằng; bài đu người hoặc bài khó chỉ khi đủ khả năng và có bảo vệ.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Trong quá trình tập luyện cần theo dõi tránh tập quá sức
- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh.
- Chú ý xử trí các tai biến trong khi tập cũng như sau khi tập:

Bất thường huyết động: dừng tập, đưa về tư thế an toàn, kiểm tra lại và báo bác sĩ; không tự dùng thuốc hạ áp.

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.
- Ngã khi tập: Chú ý cẩn thận, tránh ngã.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

21 Tập vận động trên bóng

Mã đề xuất QT VLTL 21 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Tập vận động trên bóng là bài tập cải thiện vận động hiệu quả cho trẻ bại não. Các bài tập vận động trên bong bao gồm:

- Tập kiểm soát đầu cổ, thăng bằng tư thế nằm sấp, nằm ngửa, lẫy.
- Tập thăng bằng ngồi trên bóng.
- Tập đứng với bóng.

2 Chỉ định

Trẻ bại não, chậm phát triển tinh thần, vận động. Chưa có hoặc có khả năng kiểm soát đầu cổ, lẫy, ngồi, đứng, đi kém.

3 Chống chỉ định

Trẻ sợ, khóc nhiều sau khi tập.

4 Thận trọng

Bóng đúng cỡ, tải và độ bơm; nâng đỡ đầu cổ và thân theo chức năng, luôn bảo vệ để không ngã khỏi bóng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Thảm chống trượt, vật mục tiêu an toàn.

5.4 Trang thiết bị

Bóng đúng cỡ, tải và độ bơm.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Chuẩn bị dụng cụ

Chọn bóng đúng kích thước, tải trọng và độ bơm phù hợp người bệnh theo hướng dẫn, không áp đường kính cố định.

2. Chuẩn bị người bệnh

- Giải thích cho bệnh nhi (bệnh nhi có khả năng hiểu) và gia đình bệnh nhi biết việc mình sắp làm.
- Hướng dẫn bệnh nhi (trẻ có khả năng hiểu) những điều cần thiết.
- Đi giày hoặc nẹp (nếu có) cho người bệnh
- Để trẻ làm quen với bóng trước khi tập

3. Thực hiện kỹ thuật.

- Tập kiểm soát đầu cổ, thăng bằng tư thế nằm sấp, nằm ngửa, lẫy:

+ 1 kỹ thuật viên hoặc cha/mẹ trẻ giữ bóng

+ Kỹ thuật viên đặt trẻ nằm sấp trên bóng.

+ Kỹ thuật viên đứng hoặc ngồi trên ghế phía sau người bệnh 2 tay cố định 2 khớp gối hoặc cố định tại hông.

+ Đưa bóng ra trước, ra sau, sang 2 bên hoặc lẫy trên bóng.

Thời gian và số lần tập theo lượng giá, dung nạp và chỉ định; có nghỉ, không áp thời lượng cố định cho mọi người.

- Tập thăng bằng ngồi trên bóng:

+ 1 kỹ thuật viên hoặc cha/mẹ trẻ giữ bóng

+ Đặt trẻ ngồi trên bóng

+ Kỹ thuật viên đứng hoặc ngồi trên ghế sau người bệnh 2 tay cố định tại hông trẻ.

+ Đu đưa bóng nhẹ nhàng ra trước, ra sau và sang 2 bên.

Thời gian và số lần tập theo lượng giá, dung nạp và chỉ định; có nghỉ, không áp thời lượng cố định cho mọi người.

- Tập đứng với bóng:

+ 1 kỹ thuật viên hoặc cha/mẹ trẻ giữ bóng

+ Kỹ thuật viên đặt trẻ đứng bám vào bóng

+ Kỹ thuật viên đứng hoặc ngồi trên ghế phía sau người bệnh 2 tay cố định tại hông trẻ và đẩy bóng tiến ra trước rồi lùi lại hoặc sang 2 bên.

Thời gian và số lần tập theo lượng giá, dung nạp và chỉ định; có nghỉ, không áp thời lượng cố định cho mọi người.

- Tập đi với bóng:

+ 1 kỹ thuật viên hoặc cha/mẹ trẻ giữ bóng

+ Kỹ thuật viên đặt trẻ đứng bám vào bóng

+ Đặt trẻ đứng và đẩy bóng tiến dần về phía trước, trẻ sẽ bám theo bóng tiến về phía trước.

Thời gian và số lần tập theo lượng giá, dung nạp và chỉ định; có nghỉ, không áp thời lượng cố định cho mọi người.

Nâng đỡ đầu cổ và thân theo chức năng; dừng khi sợ, khóc, đau hoặc mất kiểm soát tư thế.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Sau mỗi buổi tập, cần kiểm tra: khả năng kiểm soát đầu cổ, thăng bằng tư thế nằm sấp, nằm ngửa, lẫy, thăng bằng ngồi trên bóng, đứng với bóng.

- Trẻ bị rơi khỏi bóng nếu cố định không tốt khi tập kiểm soát đầu cổ, tập lẫy, tập ngồi

- Trẻ bị ngã khi tập đứng, đi nếu đu đưa bóng, đẩy bóng quá nhanh.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

22 Tập với thang tường

Mã đề xuất QT VLTL 22 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Thang tường là dụng cụ tập khớp vai, các cơ thân mình và chi trên.

2 Chỉ định

- Đau, hạn chế vận động khớp vai do nhiều nguyên nhân: viêm quanh khớp vai, chấn thương khớp vai, liệt nửa người, di chứng sau bó bột, bất động.
- Yếu các cơ thân mình, chi trên

3 Chống chỉ định

Người bệnh có khó khăn về nhận thức, không hiểu mệnh lệnh, không phối hợp

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày hoặc vật chống trượt.

5.4 Trang thiết bị

Thang tường neo chắc, bậc nguyên vẹn.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Tư thế người bệnh: đứng

- Tư thế kỹ thuật viên: đứng cạnh người bệnh

- Kỹ thuật viên làm mẫu, sau đó người bệnh làm theo:

Vận động có điểm tựa trong tầm không đau; không cho người yếu tay hoặc tổn thương vai treo toàn bộ trọng lượng bằng tay.

+ Cử động duỗi khớp vai: Người bệnh đứng xoay lưng lại 2 tay bám vào thang tường ngả người ra trước

+ Cử động dạng khớp vai: Người bệnh đứng nghiêng người lại với thang tường, tay nắm vào thang rồi ngả người ra

+ Cử động khép khớp vai: Người bệnh đứng đối diện với thang tường, 2 tay dạng và bám vào thang tường, ngả người về phía thang tường

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.

- Theo dõi không để người bệnh làm các cử động thay thế

- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

- Ngã khi tập: Chú ý cẩn thận, tránh ngã.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

23 Tập với ròng rọc

Mã đề xuất QT VLTL 23 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Ròng rọc là dụng cụ tập khớp vai. Ngoài ra, còn có tác dụng tập mạnh các cơ chi trên, thân mình, đặc biệt cơ lưng to.

2 Chỉ định

Đau, hạn chế vận động khớp vai do nhiều nguyên nhân:

- Viêm quanh khớp vai, chấn thương khớp vai
- Liệt nửa người
- Di chứng sau bó bột, bất động

3 Chống chỉ định

Người bệnh có khó khăn về nhận thức, không hiểu mệnh lệnh, không hợp tác

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Dây, tay cầm và đai đúng loại.

5.4 Trang thiết bị

Ròng rọc gắn chắc, êm và giới hạn phù hợp.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Tập vận động gấp duỗi khớp vai

- Tư thế người bệnh: ngồi trên ghế tựa, quay lưng lại ròng rọc, hai tay người bệnh nắm lấy hai tay cầm của ròng rọc.

- Tư thế kỹ thuật viên: Đứng bên cạnh khớp vai được treo và:

+ Xác định điểm treo: ngay tại đỉnh đầu (cho dây rơi theo trọng lực).

+ Nâng đỡ: cổ tay, bàn tay.

Tay còn chức năng hỗ trợ tay yếu trong tầm cho phép, chậm, không đau và kiểm soát bả vai; không kéo càng cao càng tốt.

+ Giữ 5-10 giây. Thư giãn, và lặp lại động tác: 10-20 lần

2. Tập vận động dạng, khép khớp vai

- Tư thế người bệnh: ngồi trên ghế tựa, ngồi nghiêng, bên vai bệnh sát với ròng rọc, hai tay nắm lấy hai tay cầm.

- Tư thế kỹ thuật viên: Đứng bên khớp vai được treo của người bệnh

+ Xác định điểm treo: ngay tại đỉnh đầu (cho dây rơi theo trọng lực).

+ Nâng đỡ: cổ tay, bàn tay.

Giới hạn độ cao theo tầm an toàn, không cố kéo qua đau hoặc vượt hạn chế sau mổ.

+ Giữ 5-10 giây. Thư giãn và lặp lại động tác: 10-20 lần

3. Tập vận động xoay trong khớp vai

- Tư thế người bệnh: đứng, quay lưng vào ròng rọc. Tay lành đưa lên trên đầu, nắm lấy tay cầm. Tay bệnh đưa ra sau lưng (sao cho ngón cái chạm vào cột sống) và nắm lấy tay cầm kia

- Tư thế kỹ thuật viên: Đứng bên khớp vai được treo

+ Xác định điểm treo: phía bên vai bệnh (cho dây rơi theo trọng lực).

+ Nâng đỡ: cổ tay, bàn tay.

+ Thực hiện cử động xoay trong khớp vai: Dùng tay lành kéo xuống, điều này giúp kéo tay bên bệnh được nâng lên cao ở phía sau lưng.

+ Giữ 5-10 giây. Thư giãn và lặp lại động tác: 10-20 lần

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.
- Theo dõi không để người bệnh làm các cử động thay thế
- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

24 Tập với dụng cụ quay khớp vai

Mã đề xuất QT VLTL 24 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Là dụng cụ tập xoay khớp vai

2 Chỉ định

- Đau, hạn chế vận động khớp vai do nhiều nguyên nhân:

+ Viêm quanh khớp vai

+ Chấn thương khớp vai

+ Liệt nửa người

+ Di chứng sau bó bột, bất động

3 Chống chỉ định

Người bệnh có khó khăn về nhận thức, không hiểu mệnh lệnh, không hợp tác

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Tay cầm và vật tư làm sạch.

5.4 Trang thiết bị

Dụng cụ quay vai điều chỉnh trục và lực cản.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kỹ thuật viên hướng dẫn làm mẫu

- Kỹ thuật viên đứng bên cạnh dụng cụ tập
- Tay của vai cần tập nắm vào tay cầm của dụng cụ tập xoay
- Xoay khớp vai từ từ theo chiều kim đồng hồ
- Xoay khớp vai ngược chiều kim đồng hồ

2. Người bệnh tự tập, kỹ thuật viên theo dõi, góp ý

- Người bệnh đứng, vai cần tập bên cạnh dụng cụ tập xoay.
- Tay nắm vào tay cầm của dụng cụ tập
- Xoay khớp vai theo chiều kim đồng hồ
- Xoay khớp vai ngược chiều kim đồng hồ

Tập theo chiều, biên độ, lực cản và thời gian chỉ định, nghỉ theo dung nạp.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.
- Theo dõi không để người bệnh làm các cử động thay thế
- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

25 Tập với giàn treo các chi

Mã đề xuất QT VLTL 25 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Giàn treo là phương tiện cần thiết để nâng đỡ và trợ giúp các phần chi thể cử động chủ động, nhằm giảm tác động của trọng lực lên các cơ suy yếu khi người bệnh không đủ sức mạnh tập luyện và tự điều khiển cử động cho hết tầm vận động.

2 Chỉ định

- Dùng cho những người bệnh trong giai đoạn đầu của chương trình tập luyện cơ.
- Những trường hợp người bệnh vận động không đúng mẫu.
- Những trường hợp giới hạn tầm vận động của khớp.
- Những trường hợp người bệnh thiếu cố gắng và hợp tác tập luyện.

3 Chống chỉ định

- Những trường hợp đau làm ngăn cản cử động chủ động.
- Người bệnh hoàn toàn không hợp tác tập luyện.
- Khi các vị thế được lựa chọn: nằm ngửa, nằm nghiêng và ngồi là chống chỉ định.

4 Thận trọng

Kiểm tra tải, điểm neo, khóa, dây và vùng tỳ. Bảng giải phẫu tham khảo không thay cài đặt theo thiết bị và từng người; không treo toàn thân trên giàn chỉ dùng cho chi.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Dây, đai, móc khóa và đệm.

5.4 Trang thiết bị

Giàn treo chi đã kiểm tra neo, tải và trục.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ

2. Kiểm tra người bệnh

3. Thực hiện kỹ thuật

- Xác định tầm vận động khớp và sức cơ bằng tay kỹ thuật viên.

- Chọn tư thế khởi đầu sao cho người bệnh thực hiện đúng mẫu động tác mong muốn, đồng thời đảm bảo sự vững chắc và thoải mái cho người bệnh.

- Lựa chọn dụng cụ cần thiết như móc, dây treo, đai v.v...

- Buộc dụng cụ vào giàn treo.

- Buộc dụng cụ vào người bệnh: từ phần gần đến phần xa.

- Xác định điểm treo bằng cách thả cho dây rơi theo đường trọng lực.

+ Nếu nhằm mục đích thực hiện cử động, điểm treo phải nằm trên đường thẳng đứng trên trục cử động.

+ Nếu nhằm mục đích nâng đỡ, điểm treo phải nằm trên đường thẳng đứng trên trọng tâm của phần chi thể được treo

- Chỉ gắn dây treo vào đai khi đã buộc đai chính xác vào vùng cơ thể cần điều trị.
- Giải thích cho người bệnh rõ cử động mẫu mà họ phải làm
- Giữ vững chắc xương nơi có điểm bám của cơ được tập.
- Khi tháo gỡ: tháo từ xa tới gần, sau đó tháo dụng cụ trên giàn.

KỸ THUẬT TREO

Bảng giải phẫu kế thừa nguồn chỉ để tham khảo chuẩn bị; khoảng cách không thay hướng dẫn thiết bị và hiệu chỉnh từng người. Khoa thẩm định trước dùng để cài đặt.

Khớp	Cử động	Vị thế người bệnh	Điểm treo	Nâng đỡ	Giữ vững
VAI	Gập Duỗi	Nằm nghiêng	Dưới mỏm cùng vai 2,5cm	Cổ - bàn tay, khuỷu	Vai
VAI	Dạng khép	Nằm ngửa	Mỏm cùng vai xuống 2,5cm	Cổ - bàn tay, khuỷu	Vai
VAI	Xoay trong Xoay ngoài	Ngồi, khuỷu gập 90o	Mỏm cùng vai vào 2,5cm	Cổ tay - Bàn tay	Cánh tay
VAI	Xoay trong Xoay ngoài	Nằm nghiêng, vai dạng 90o	Dưới mỏm cùng vai 2,5cm	Cổ tay - Bàn tay	Vai
KHUỶU	Gấp Duỗi	Nằm nghiêng	Ngay tại khớp khuỷu	Cánh tay, cổ tay &bàn tay	Cánh tay
KHUỶU		Ngồi, vai dạng 90o	Ngay tại khớp khuỷu	Cánh tay, cổ tay & bàn tay	Cánh tay
HÁNG	Gấp Duỗi	Nằm nghiêng	- Mấu chuyển lớn lên 2,5cm	Gối, cổ chân & bàn chân	Chân
			- Mào chậu xuống 4 ngón tay		
	Dạng khép	Nằm ngửa	Điểm giữa đường xếp háng xuống 2,5cm	Gối, cổ chân & bàn chân	Chân
GỐI	Gấp Duỗi	Nằm nghiêng	Ngay tại khớp	Đùi, cổ chân & bàn chân	Đùi

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Trong tất cả mọi trường hợp nên đặt 2 đầu của đai cách khoảng bằng nhau ở 2 bên phần chi thể hay thân mình để duy trì đai đúng vị thế.
- Kiểm tra các đầu móc, dây và đai treo phải chắc chắn, an toàn. Tránh xoắn vặn khi treo.

1. Buộc hai đầu móc chắc chắn phòng ngừa tai nạn.

2. Dây và đai treo bị đứt hay xơ rách không được sử dụng cho người bệnh.

3. Phần chi thể gần cần được nâng lên trước rồi đến phần xa.

Chỉ áp dụng treo chi. Treo toàn thân cần hệ thống được phép, nhân sự đủ năng lực và quy trình riêng đã duyệt.

5. Chăm sóc dụng cụ:

- Dụng cụ phải được giữ trong tình trạng tốt bằng cách kiểm tra và cất ngay khi sử dụng.

- Dùng xong treo từng dây và đai treo lên móc theo từng loại riêng biệt để tránh xoắn vặn.

- Giữ sạch đai và dây treo bằng cách giặt thường xuyên.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

26 Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi

Mã đề xuất QT VLTL 26 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Ghế tập cơ tứ đầu đùi hỗ trợ duỗi gối có kháng trở; chọn tải, tầm và cơ đích theo thiết kế ghế và chức năng.

2 Chỉ định

Tập mạnh cơ tứ đầu đùi, tam đầu đùi có bậc thử cơ từ bậc 3 trở lên trong một số bệnh thần kinh trung ương và ngoại biên:

- Tai biến mạch máu não

- Chấn thương sọ não

- Chấn thương tủy sống

- Tổn thương thần kinh ngoại biên

- Trước khi lắp chân giả

3 Chống chỉ định

- Tăng huyết áp

- Suy tim

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Đai, đệm và tải định mức.

5.4 Trang thiết bị

Ghế cơ tứ đầu đùi ổn định, chỉnh trục và tầm.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Cho người bệnh ngồi ngay ngắn trên ghế tập, giữ thân mình thẳng, hai vai cân đối, để chân định tập vào đúng vị trí (tập lần lượt từng chân đối với những trường hợp cần tập 2 chân).
- Kỹ thuật viên, người nhà hoặc người bệnh tự lắp đối trọng phù hợp với mình.
- Tiến hành tập gấp duỗi gối 10-20 lần, nghỉ 2-3 phút sau đó tiếp tục tập cho đến khi hết thời gian.
- Thời gian tập từ 15-30 phút tùy theo tình trạng sức khỏe cũng như khả năng của người bệnh.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh.

- Theo dõi huyết áp.

- Theo dõi không để người bệnh làm các cử động thay thế, như gập háng, nhấc mông….

- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh để tăng hoặc giảm lực kháng trở.

Bất thường huyết áp: dừng tập, nghỉ ở tư thế an toàn, kiểm tra lại và báo bác sĩ; thuốc chỉ theo y lệnh.

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

27 Tập với xe đạp tập

Mã đề xuất QT VLTL 27 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Xe đạp tập là dụng cụ tập luyện trong phục hồi chức năng để làm tăng sức mạnh của cơ cũng như tầm vận động các khớp chi dưới, tăng khả năng giữ thăng bằng của người bệnh. Thiết bị đặt cố định, có cấu trúc như xe đạp nhưng không có bánh xe, có thể điều chỉnh được lực kháng trở tùy theo khả năng và sự tiến triển của người bệnh. Một số xe đạp tập có cấu tạo để tập cả chi trên.

2 Chỉ định

- Tai biến mạch máu não

- Chấn thương sọ não

- Chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống

- Thoái hóa khớp gối, háng

- Hạn chế vận động khớp cổ chân, gối, háng sau chấn thương.

3 Chống chỉ định

- Tăng huyết áp

- Người bệnh mất nhận thức, không hợp tác

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày, khăn, đai giữ chân nếu yêu cầu.

5.4 Trang thiết bị

Xe đạp chỉnh yên và lực cản, bộ dừng.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Giúp người bệnh ngồi lên yên xe, hai tay cầm vào tay nắm ghi đông của xe (với người bệnh liệt chi trên dùng băng dán cố định tay người bệnh vào ghi đông).

- Thực hiện động tác như đạp xe, thời gian tập từ 15- 30 phút tùy theo tình trạng sức khỏe, khả năng của người bệnh. Trong thời gian tập có thể nghỉ 1-2 lần, thời gian mỗi lần từ 2-3 phút.

- Kỹ thuật viên luôn có mặt trong phòng tập để phát hiện những tai biến xảy ra để xử trí kịp thời.

- Trường hợp người bệnh nặng người nhà có thể đứng bên cạnh hỗ trợ.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Theo dõi có biểu hiện quá sức ở người bệnh. Theo dõi huyết áp.

- Theo dõi sự tiến triển của người bệnh để tăng hoặc giảm lực kháng trở.

Bất thường huyết áp: dừng tập, nghỉ ở tư thế an toàn, kiểm tra lại và báo bác sĩ; thuốc chỉ theo y lệnh.

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

28 Tập thăng bằng với bàn bập bênh

Mã đề xuất QT VLTL 28 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

- Bàn bập bênh là một trong những dụng cụ tập thăng bằng cho người bệnh.

- Tập với bàn bập bênh là bài tập thăng bằng ở mức độ khó.

- Với bàn bập bênh có thể tập thăng bằng cho người bệnh ở tư thế ngồi hoặc đứng.

2 Chỉ định

Người bệnh chuẩn bị quay trở lại công việc hay những hoạt động kiểm soát các cử động điều hợp nhanh hay chậm trong các bệnh:

- Liệt nửa người

- Liệt hai chân

- Parkinson

- Viêm đa dây đa rễ thần kinh

- Xơ cứng rải rác

- Xơ cứng cột bên teo cơ,

- Bại não

- Chậm phát triển vận động tinh thần

- Yếu cơ sau chấn thương chi dưới, sau phẫu thuật chi dưới…

- Đoạn chi, lắp chân giả các loại

3 Chống chỉ định

Người bệnh có rối loạn tri giác nhận thức, không hiểu lệnh và không điều khiển được các cử động của cơ thể.

4 Thận trọng

Bắt đầu có tay vịn hoặc người bảo vệ; nhắm mắt, đứng một chân là tiến triển chọn lọc khi đạt tiêu chí.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Giày chống trượt và đai nếu cần.

5.4 Trang thiết bị

Bàn bập bênh, thảm, tay vịn.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ

Lựa chọn bài tập và kỹ thuật phù hợp với tình trạng khiếm khuyết của người bệnh để có thể đạt được mục đích tốt nhất.

2. Kiểm tra và chuẩn bị người bệnh

- Giải thích mục đích bài tập và quy trình tập cho người bệnh hiểu để họ hợp tác tốt, tạo sự tin tưởng và làm người bệnh thư giãn.

- Đặt người bệnh trong tư thế thoải mái, vững chắc và ổn định để cho phép người bệnh thực hiện được bài tập tốt nhất khi thực hiện quy trình.

- Dùng các kỹ thuật thư giãn trước khi tập ngồi thăng bằng tĩnh và động nếu người bệnh co co cứng cơ ở các chi hay thân mình.

3. Thực hiện bài tập

- Tập thăng bằng ngồi:

+ Người bệnh ngồi, người điều trị đứng phía sau hay phía trước người bệnh, giữ khung chậu, yêu cầu người bệnh dang hai tay ra, dồn trọng lượng sang từng bên hông hoặc thay đổi tư thế tay và đầu ở các hướng hướng trong không gian. Một khi phản ứng thăng bằng của người bệnh được tạo thuận thì nhiều cử động chi thể sẽ được thực hiện. Những cử động này liên quan đến mức độ cố gắng người bệnh để duy trì thăng bằng.

Nếu phản ứng thăng bằng thất bại thì phản ứng duỗi bảo vệ của cánh tay là một trong những phản ứng quan trọng nhất cần được tập để người bệnh chống đỡ khi mất thăng bằng.

- Tập thăng băng đứng:

Người hướng dẫn bảo vệ thân và khung chậu, dùng đai hoặc tay vịn phù hợp; không giữ hoặc kéo đầu, cổ hay vai yếu để chống ngã.

+ Yêu cầu người bệnh nâng hai tay ra phía trước, dồn trọng lượng sang từng bên chân hoặc thay đổi tư thế đầu ở các hướng trong không gian. Một khi phản ứng thăng bằng của người bệnh được tạo thuận thì nhiều cử động chi thể sẽ được thực hiện. Những cử động này liên quan đến mức độ cố gắng người bệnh để duy trì thăng bằng.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Kiểm tra tình trạng huyết áp, chỉ số mạch an toàn đối với những người bệnh nằm lâu trước đó. Nếu người bệnh chóng mặt, mệt thì nên ngừng tập và để người bệnh nằm nghỉ.

Bất thường huyết áp: dừng tập, nghỉ ở tư thế an toàn, kiểm tra lại và báo bác sĩ; thuốc chỉ theo y lệnh.

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

- Ngã khi cử động tay, thân và đầu để tập thăng bằng động đặc biệt ở những người bệnh tai biến mạch não, chấn thương sọ não hay liệt hai chân do tổn thương tủy. Người điều trị cần đứng gần người bệnh ở phía trước hay bên liệt để hỗ trợ người bệnh kịp thời khi cần.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

29 Kỹ thuật kéo nắn trị liệu

Mã đề xuất QT VLTL 29 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Kéo nắn trị liệu là can thiệp bằng tay trên khớp, sau khám xác định chỉ định, loại trừ tổn thương cấu trúc và nguy cơ thần kinh mạch máu.

- Tắc nghẽn khớp là sự hạn chế độ trượt các diện của mỗi khớp lên nhau:

+ Nguyên nhân: do rối loạn điều hòa cơ; sau chấn thương; một số bệnh khớp; kích thích phản xạ bệnh lý nội tạng

Đau và hạn chế vận động không đủ để tự kết luận tắc nghẽn khớp; khám và chọn xét nghiệm theo chẩn đoán, dấu hiệu cảnh báo.

2 Chỉ định

Chỉ định kéo nắn khi có tắc nghẽn khớp độ II (Stoddart phân ra làm 5 mức độ):

- Độ 0: Cứng khớp, do nguyên nhân bệnh lý nào đó làm cho 2 đầu xương của khớp bị dính lại. Trong trường hợp này không thể kéo nắn được, không những không có kết quả mà còn gây tai biến.

- Độ I: Tắc nghẽn nặng, trong trường hợp này người bệnh đau nhiều và hạn chế cử động. Vì vậy không nên kéo nắn trực tiếp mà phải chuẩn bị tốt bằng điều trị vật lý như nhiệt nóng trị liệu, xoa bóp trị liệu, di động khớp sau đó mới tiến hành kéo nắn.

- Độ II: Tắc nghẽn khớp thực sự, chỉ định kéo nắn là tốt nhất.

- Độ III: Khớp hoạt động bình thường không cần kéo nắn

- Độ IV: Khớp bị lỏng không cần kéo nắn

3 Chống chỉ định

- Gãy xương, trật khớp, đứt dây chằng khớp

- Các khối u lành tính và ác tính

- Các trường hợp có nguy cơ chảy máu

- Bệnh lý cột sống: viêm tủy, lao cột sống, chấn thương cột sống, hội chứng rễ…

- Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai.

4 Thận trọng

Kéo nắn xung lực, nhất là cổ, có nguy cơ thần kinh mạch máu. Mô tả chung không đủ hướng dẫn thực hành; phải có quy trình theo khớp và năng lực được xác nhận.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ đủ phạm vi hành nghề và năng lực kéo nắn được bệnh viện xác nhận trực tiếp thực hiện; nhân viên khác hỗ trợ, không giao xung lực cho người chưa được phép.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Đai, vật bảo vệ khi chỉ định.

5.4 Trang thiết bị

Bàn trị liệu, phương tiện khám và gọi cấp cứu.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Bác sĩ xác định chẩn đoán, khớp đích, loại trừ chống chỉ định và khám thần kinh mạch máu.

Bước 2. Giải thích lợi ích, lựa chọn thay thế, nguy cơ; ghi chấp thuận theo yêu cầu. Xác nhận người thực hiện và quy trình chuyên biệt được phép.

Bước 3. Chỉ thực hiện theo hướng, lực và biên độ của quy trình chuyên biệt đã duyệt. Chưa có quy trình và xác nhận năng lực thì không tiến hành xung lực từ mô tả tổng hợp này.

Bước 4. Dừng khi đau bất thường, chóng mặt, rối loạn thị giác, yếu hoặc tê mới; đánh giá và gọi hỗ trợ.

Bước 5. Khám lại thần kinh mạch máu, đau, chức năng, ghi kỹ thuật và hướng dẫn sau can thiệp.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp và tình trạng người bệnh trước và sau thực hiện kỹ thuật kéo nắn.
- Theo dõi người bệnh có bị chấn thương hay không.
- Tai biến: chấn thương khớp, gãy xương, đau.
- Xử trí: giảm đau, xử trí theo mức độ chấn thương.
- Rất thận trọng khi kéo nắn cột sống cổ vì có thể gây chấn thương tủy sống dẫn đến liệt tứ chi.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

30 Kỹ thuật di động khớp

Mã đề xuất QT VLTL 30 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

1. Định nghĩa

Di động khớp là các vận động cần thiết cho các chức năng thông thường của khớp qua tầm vận động mà người bệnh không thể tự thực hiện được như kéo, tách, trượt, ép, lăn và xoay tròn của các mặt khớp. Đây là loại vận động phụ trợ của khớp.

2. Các loại kỹ thuật

Có 7 loại kỹ thuật di động khớp gồm trượt khớp, kéo nắn khớp, lăn khớp, xoay tròn khớp, kéo dãn khớp khi trượt, kéo tách khớp, ép khớp

2 Chỉ định

1. Giảm đau, giảm co cứng cơ và co thắt cơ

Các vận động lúc lắc biên độ nhỏ của khớp kích thích bộ phận nhận cảm cơ, do đó ức chế dẫn truyền kích thích nhận cảm đau ở tuỷ sống hoặc thân não làm giảm đau, từ đó giảm phản xạ co cứng, co thắt cơ và các tổ chức phần mềm quanh khớp, tạo nên sự chuyển dịch của dịch trong bao hoạt dịch, đưa các chất dinh dưỡng đến phần vô mạch của sụn khớp, phòng ngừa các tác động của sự thoái hoá khi khớp xưng đau làm vận động không hết tầm độ bình thường hay do bất động khớp.

2. Điều trị sự giảm vận động khớp hai chiều

Sử dụng kỹ thuật kéo dãn có trượt khớp tăng tiến để làm dài các cấu trúc bị giảm vận động, lực kéo dãn hoặc rung lắc ở mức độ vừa phải và chịu được để làm dãn dài các mô đã bị co ngắn, từ đó có thể điều trị sự giảm vận động khớp hai chiều

3. Điều trị các giới hạn tầm vận động khớp tiến triển

Duy trì được khả năng vận động, làm chậm sự tiến triển hạn chế vận động khớp do vậy điều trị được sự hạn chế vận động khớp tiến triển

4. Điều trị khi người bệnh phải bất động chức năng

Duy trì khả năng trượt khớp, vận động khớp, phòng ngừa thoái khớp và co rút mô mềm, bao khớp.

3 Chống chỉ định

1. Chống chỉ định tuyệt đối

- Khớp vận động lỏng lẻo do bị hoại tử, rách, đứt các dây chằng và bao khớp.

- Tràn dịch khớp do chấn thương, do bệnh gây ra. Hạn chế vận động khớp do dịch tăng lên và phản ứng cơ gây đau chứ không phải do co ngắn các tổ chức quanh khớp.

- Nhiễm trùng khớp: khi khớp bị viêm nhiễm, di động khớp sẽ làm tăng đau, co cơ phản xạ bảo vệ làm các mô bị tổn thương nặng thêm.

2. Chống chỉ định tương đối

- Người bệnh có các khối u ác tính
- Người bệnh có bệnh lý về xương có thể phát hiện bằng Xquang.
- Người bệnh bị gãy xương chưa lành (tuỳ thuộc vào vị trí gãy và kỹ thuật cố định)
- Người bệnh đau quá mức (xác định nguyên nhân gây đau)
- Khớp tăng động trong phản ứng liên hợp của các khớp. Các khớp khác phải được cố định đúng để lực vận động của khớp đang điều trị không truyền đến chúng.
- Người bệnh đã được phẫu thuật thay khớp toàn bộ.

4 Thận trọng

Phân biệt di động khớp với kéo nắn xung lực; mất vững, viêm cấp, loãng xương, chống đông cần đánh giá trước chọn lực.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Đai, gối, khăn.

5.4 Trang thiết bị

Bàn trị liệu, dụng cụ đo tầm khi cần.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ và lựa chọn kỹ thuật

- Để điều trị tình trạng đau kéo dài: nên sử dụng các kỹ thuật lắc khớp

- Để điều trị tình trạng mất vận động trượt khớp làm hạn chế vận động: nên sử dụng các kỹ trượt khớp

- Để duy trì tầm vận động khớp: nên sử dụng các kỹ thuật lắc khớp hoặc trượt khớp ở mức độ 2.

- Để duy trì sự trượt khớp: khi không thể sử dụng các kỹ thuật tập theo tầm vận động hoặc khớp không được cử động trong một khoảng thời gian thì sử dụng kỹ thuật lắc khớp ở mức độ 2 hay kéo dãn khớp ở mức độ 2

- Nên sử dụng kỹ thuật trượt khớp cùng với các kỹ thuật kéo dãn khớp mức độ 1. Tránh sử dụng kỹ thuật kéo dãn khớp mức độ 2 hoặc 3 cùng lúc với kỹ thuật trượt khớp mức độ 3 vì sẽ gây tổn thương thêm cho khớp.

- Khi sử dụng các kỹ thuật kéo dãn khớp: đầu tiên cử động phần xương chung qua tầm trượt khớp cho phép để làm mềm khớp, khi cảm thấy kháng trở thì áp dụng kỹ thuật kéo dãn hoặc tách khớp để vượt qua sự kháng trở đó.

2. Kiểm tra người bệnh

Người bệnh và các chi được điều trị ở trong tư thế thư giãn, chắc chắn. Các bài tập thư giãn có thể sử dụng trước và trong khi áp dụng các kỹ thuật di động khớp.

3. Vị trí của khớp

Khớp được đặt trong vị trí được nghỉ ngơi, bao khớp được thư giãn tối đa để ít gây đau nhất.

4. Thực hiện cố định tốt: Có thể cố định bằng băng, đai, bằng tay của người điều trị. Phương pháp cố định phải chắc chắn nhưng thoải mái đối với các khớp có liên quan, thường là cố định ở phần gần trung tâm xương.

5. Cung cấp lực điều trị

Lực điều trị dù mạnh hay nhẹ nhưng cần phải được tác động ở càng gần mặt khớp càng tốt. Bề mặt tiếp xúc càng lớn thì các thao tác càng dễ dàng và thoải mái.

Thay bằng sử dụng lực tác động của các đầu ngón tay, người điều trị sử dụng phần mặt phẳng của bàn tay để cung cấp lực tác động.

6. Xác định hướng của vận động

- Người điều trị phải xác định được hướng của vận động là vuông góc trong kỹ thuật kéo dãn khớp và tách khớp hay là song song với mặt phẳng điều trị trong kỹ thuật trượt khớp.

- Mặt phẳng điều trị là mặt phẳng vuông góc với đường thẳng từ trục của xương xoay vòng đến điểm giữa mặt lõm của bề mặt khớp. Mặt phẳng điều trị là phần mặt lõm do đó vị trí của nó được xác định bởi vị trí của xương lõm.

7. Tốc độ, nhịp điệu và thời gian thực hiện kỹ thuật di động khớp

7.1. Đối với kỹ thuật lắc khớp

Áp dụng nhịp nhàng, lắc đều từ 2-3 lần trong một giây trong thời gian 1-2 phút. Có thể thực hiện với biên độ thấp và tốc độ cao để ức chế đau hay biên độ thấp và tốc độ chậm để thư giãn cơ bảo vệ.

7.2. Đối với kỹ thuật kéo dãn khớp

Nếu các khớp đau nhiều, áp dụng kỹ thuật kéo ngắt quãng trong 10 giây, nghỉ vài giây giữa các lần kéo dãn. Nếu các khớp có hạn chế vận động, sử dụng kỹ thuật kéo dãn khớp với lực nhỏ trong 6 giây, sau đó giảm lực một phần đến mức độ 1 hoặc 2 rồi lặp lại trong khoảng 3-4 giây.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

1. Ngày đầu tiên điều trị

Để khớp nghỉ ngơi hoặc thư giãn tối đa để giảm đau và làm mềm khớp.

2. Ngày thứ hai

- Nếu đau tăng lên, tăng nhạy cảm khớp, giảm xuống vận động lắc mức độ 1.

- Nếu không đau hay khớp dễ chịu hơn, làm lại kỹ thuật kéo dãn khớp mức độ 2 nếu mục đích điều trị để duy trì trượt khớp hoặc sử dụng bài tập kéo dãn mức độ 3, trượt khớp mức độ 3 nếu mục đích điều trị là tăng cường trượt khớp.

3. Những ngày tiếp theo

- Khi tầm vận động khớp đã khá lên hoặc vận động khớp hết tầm vận động, sử dụng các kỹ thuật kéo dãn mức độ 3, trượt khớp mức độ 3.

- Tăng tiến điều trị bằng sử dụng kỹ thuật xoay một phần ở cuối tầm vận động trước khi trượt hay kéo dãn khớp mức độ 3.

Nghi tổn thương: ngừng, bảo vệ, đánh giá thần kinh mạch máu và báo bác sĩ; bất động, thuốc, thời gian phục hồi theo tổn thương cụ thể, không cố định chung 21 ngày.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

31 Kỹ thuật di động mô mềm

Mã đề xuất QT VLTL 31 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

- Di động mô mềm là kỹ thuật được thực hiện bằng tay, sử dụng những lực kéo dãn nhỏ tác động đến các tổ chức mềm như da, tổ chức dưới da, cơ, cân mạc, dây chằng, bao khớp để làm tăng sự mềm dẻo, di động của những tổ chức này. Kỹ thuật này

phát triển từ hơn 20 năm nay, được sử dụng rộng rãi trong điều trị phục hồi chức năng các tình trạng bệnh lý cơ xương khớp khác nhau.

- Di động mô mềm bao gồm các thao tác xoa bóp, kéo dãn theo chiều dọc, di động theo chiều ngang kết hợp với lực ép xuống thích hợp nhằm làm di động các tổ chức phần mềm.

- Mục đích và tác dụng:

+ Lưu thông tuần hoàn máu, bạch huyết.

+ Giảm phù nề tại chỗ, giúp phục hồi các mô bị tổn thương.

+ Thư dãn cơ bị co cứng giúp gia tăng tầm vận động khớp, phục hồi các chức năng vận động.

+ Phá vỡ sự kết dính, làm mềm các mô sẹo hoặc các tổ chức xơ sợi, kém đàn hồi.

+ Giảm đau, thư dãn, phục hồi sức khỏe.

2 Chỉ định

- Hạn chế tầm vận động khớp do nguyên nhân mô mềm

- Sẹo bỏng ngoài da

- Co cứng cơ trong các bệnh lý cột sống như thoái hóa, biến dạng bẩm sinh, thoát vị đĩa đệm…

- Viêm bao gân vùng mỏm trâm quay (hội chứng De Quervain), viêm lồi cầu xương cánh tay (hội chứng Tennis elbow), ngón tay lò xo, hội chứng đường hầm cổ tay…

3 Chống chỉ định

- Các tổn thương ngoài da cấp tính như loét, vết thương hở, viêm nhiễm khuẩn

- Bệnh tự miễn, tắc mạch

- Các tổn thương tại xương khớp như gãy xương, trật khớp.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Khăn, chất tiếp xúc phù hợp nếu cần.

5.4 Trang thiết bị

Bàn hoặc ghế trị liệu.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Giải thích cho người bệnh rõ về mục đích và các bước tiến hành kỹ thuật. Hướng dẫn người bệnh cách tự theo dõi các biến chứng hoặc tác dụng phụ không mong muốn, hoặc các biểu hiện bệnh lý cần cấp cứu ngay trong khi thực hiện kỹ thuật.

2. Hướng dẫn người bệnh tư thế nằm hoặc ngồi đúng, thoải mái, thuận tiện để có thể thực hiện được kỹ thuật

3. Nhẹ nhàng thực hiện các thao tác xoa bóp, kéo dãn theo chiều dọc, di động theo chiều ngang kết hợp với lực ép xuống thích hợp nhằm làm di động các tổ chức phần mềm, trong khi không gây cảm giác khó chịu hay đau đớn cho người bệnh.

4. Trong khi thực hiện kỹ thuật, phải luôn lưu ý hỏi người bệnh về cảm giác của họ (đau, khó chịu, căng tức…hay thoải mái, thư dãn, giảm đau) để quyết định lực tác động thích hợp.

5. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15 - 30 phút cho 1 nhóm cơ hay một đoạn chi, một vùng cơ thể tùy theo tình trạng bệnh lý.

6. Kết thúc kỹ thuật phải kiểm tra lại tình trạng đau, mức độ co cứng, tầm vận động khớp, cơ lực, cảm giác của người bệnh.

7. Ghi chép hồ sơ bệnh án.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Tại vùng điều trị cần theo dõi phát hiện sớm các biến chứng thứ phát như đau, phù nề, tăng co cứng cơ hoặc các biểu hiện viêm tại chỗ do lực tác động quá lớn hoặc không đúng.

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

32 Xoa bóp trị liệu

Mã đề xuất QT VLTL 32 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Xoa bóp bằng tay là những thủ thuật xoa nắn các mô một cách có khoa học và hệ thống nhằm tác động lên các cơ, hệ thần kinh, hệ tuần hoàn.

2 Chỉ định

- Làm giãn cơ, giảm đau.
- Kích thích hoặc làm êm dịu hệ thần kinh.
- Điều trị dính của các mô.

Hỗ trợ thư giãn, giảm căng và đau cơ theo chỉ định.

- Trước khi thực hiện các kỹ thuật vận động khác hoặc kỹ thuật kéo nắn.

3 Chống chỉ định

- Viêm nhiễm cấp tính, viêm tắc tĩnh mạch, các khối u.
- Các bệnh ngoài da.

4 Thận trọng

Xác nhận giới hạn tầm vận động, chịu tải và bảo vệ sau mổ; đánh giá đau, cảm giác, thần kinh mạch máu và khả năng phối hợp. Người yếu, liệt, loãng xương hoặc giảm thăng bằng cần hỗ trợ; không kéo tay bên liệt, không nâng bằng nách. Dừng khi đau tăng, chóng mặt hoặc mất ổn định.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Khăn, tấm phủ, chất bôi trơn phù hợp da.

5.4 Trang thiết bị

Giường trị liệu bảo đảm riêng tư.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Tạo tâm lý tiếp xúc tốt với người bệnh: giải thích cho người bệnh hiểu rõ được bệnh tật của mình để hợp tác điều trị.

2. Kỹ thuật

- Xoa dầu hoặc thuốc mỡ lên vùng xoa bóp.

- Kỹ thuật xoa vuốt: dùng hai bàn tay trượt nhẹ nhàng, dịu dàng lên phần cơ thể được xoa bóp, xoa vuốt theo chiều dọc hay xoa thành vòng tròn.

+ Xoa vuốt nông.

+ Xoa vuốt sâu: trong trường hợp cơ bị co, làm tăng tuần hoàn máu và bạch huyết.

- Kỹ thuật nhào bóp

+ Nhào bóp nhẹ để làm cho cơ chùng xuống và thư giãn cơ.

Nhào bóp với lực phù hợp, không đau; không coi xoa bóp thay bài tập tăng sức mạnh.

- Kỹ thuật cọ xát.

- Kỹ thuật vỗ (gõ).

- Kỹ thuật rung.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Tình trạng người bệnh.

- Màu sắc vùng da nơi xoa bóp.

- Nếu có những diễn biến xấu cần ngừng xoa bóp ngay và báo cáo với bác sĩ chuyên khoa Phục hồi chức năng.

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

33 Tập cơ đáy chậu

Mã đề xuất QT VLTL 33 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

- Tập cơ đáy chậu là tập luyện sự siết chặt và thư giãn lặp lại một cách chủ động có chọn lọc các cơ vùng đáy chậu. Phục hồi chức năng cơ vùng đáy chậu là một phương pháp quan trọng để kiểm soát rỉ tiểu.

- Bài tập làm mạnh cho các cơ vùng đáy chậu hay còn gọi là bài tập Kegel có thể đem lại lợi ích cho cả nam giới và phụ nữ, đặc biệt với những người không kiểm soát được tiểu tiện. Ở nữ giới bài tập Kegel hay được áp dụng hơn nhằm kiểm soát tốt hơn khi tăng áp lực trong ổ bụng ví dụ khi ho, hắt hơi, cười và giúp phụ nữ lấy lại tự tin, nhất là sau khi sinh con. Tuy nhiên, việc tập luyện chương trình Kegel cần thực hiện một cách chính xác và đều đặn.

2 Chỉ định

Rối loạn chức năng sàn chậu đã được bác sĩ đánh giá và chỉ định phù hợp; đau hoặc cảm giác sa cần xác định nguyên nhân trước chọn bài tập.

- Sa sinh dục mức độ nhẹ khi người bệnh ở tư thế tự nhiên.
- Rỉ tiểu gắng sức, rỉ tiểu cấp
- Người bệnh đi tiểu nhiều lần
- Người bệnh đại tiện không tự chủ

3 Chống chỉ định

Người bệnh bị bệnh tim nặng

4 Thận trọng

Đánh giá co và thư giãn; đau hoặc tăng trương lực đáy chậu không mặc định cần tăng sức mạnh. Bảo đảm đồng thuận, riêng tư; không tập ngắt dòng tiểu thường xuyên.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Tấm phủ, vệ sinh tay, vật tư khám khi chỉ định.

5.4 Trang thiết bị

Giường hoặc ghế riêng tư; phản hồi sinh học cần quy trình riêng.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Hỏi triệu chứng, tiền sử, mục tiêu và đau; đánh giá phù hợp trước chọn bài.

Bước 2. Giải thích và kiểm tra co, thư giãn đúng cơ đáy chậu, không gồng mông, bụng hay nín thở.

Bước 3. Chọn tư thế thoải mái; co và nâng cơ quanh niệu đạo, hậu môn, giữ theo khả năng rồi thư giãn hoàn toàn.

Bước 4. Đặt số lần, thời gian giữ, nghỉ và số buổi theo lượng giá; phối hợp co nhanh hoặc hoạt động khi đã thực hiện đúng. Không tập trong lúc đi tiểu.

Bước 5. Đánh giá lại, giảm hoặc dừng khi đau, tiểu khó, tăng căng; ghi chương trình tự tập và lịch đánh giá.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi và hướng dẫn người bệnh làm đúng động tác, kiểm tra từng giai đoạn để sửa những sai sót của người bệnh tránh thành thói quen xấu, không có hiệu quả

Đau cơ: dừng hoặc giảm bài, đánh giá và báo bác sĩ; thuốc giảm đau hoặc phương thức điều trị chỉ theo chỉ định.

- Tập quá sức: Nghỉ ngơi.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

Tài liệu đối chiếu

1. NICE NG123, mục đánh giá cơ đáy chậu và tập có giám sát ở phụ nữ; không mở rộng thành hướng dẫn cho mọi nhóm bệnh. Nguồn đối chiếu

34 Tập khéo léo bàn tay

Mã đề xuất QT VLTL 34 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Bàn tay là công cụ đặc biệt giúp chúng ta thực hiện được các hoạt động sống hàng ngày. Chính vì vậy khi giảm chức năng bàn tay, hơn tất cả các vùng khác trên cơ thể, bàn tay cần phải được chú ý, điều trị và phục hồi chức năng sớm và tốt nhất.

2 Chỉ định

Mất hoặc giảm chức năng khéo léo của bàn tay.

3 Chống chỉ định

Người bệnh đang trong giai đoạn cấp của bệnh

4 Thận trọng

Chọn vật theo tuổi, cảm giác, nhận thức; tránh vật sắc và hạt nhỏ khi nguy cơ sặc, không dùng thuốc lá.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Đất nặn, kẹp, khối an toàn theo tuổi.

5.4 Trang thiết bị

Bàn ghế vừa tầm và dụng cụ hoạt động trị liệu.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Bước 1: Lượng giá khiếm khuyết bàn tay của người bệnh

2. Bước 2: Phân tích ảnh hưởng của khiếm khuyết bàn tay lên chức năng:

- Mất hoặc giảm khả năng đưa tay với đồ vật ?

- Có cầm nắm, buông đồ vật bằng bàn tay ?

- Có thực hiện được các chức năng sinh hoạt hàng ngày không ?

3. Bước 3: Lập mục tiêu điều trị tổng quát thích hợp.

- Tách rời ngón.

- Cầm nắm đồ vật bằng các cách.

- Kẹp đồ vật.

4. Bước 4: Lập chương trình điều trị theo mục tiêu.

5. Bước 5: Thực hiện chương trình điều trị

- Tách rời các ngón tay (ấn số lên bảng số của máy điện thoại, gõ lên bàn phím máy vi tính...)

Kẹp và chuyển vật mô phỏng an toàn, không dùng điếu thuốc.

- Kẹp một bên hoặc cầm nắm với ngón cái và ngón trỏ (cầm một chìa khóa, cắt thịt…)

- Đối chiếu ngón cái ngón trỏ (sờ lên vải, lật trang sách…)

- Kẹp tròn (nhặt hạt, xâu chỉ vào lỗ kim, lấy kẹp giấy trên bàn…)

Cuộn giấy hoặc vật liệu thủ công an toàn, không tập cuốn thuốc lá.

6. Bước 6: Đánh giá hiệu quả của chương trình điều trị

Đánh giá sau tập luyện 1 tuần, 2 tuần, 4 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm...

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

1. Trong khi tập

- Xem người bệnh có đau, khó chịu.
- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở và tình trạng toàn thân.
- Theo dõi hàng ngày và ghi vào hồ sơ bệnh án theo dõi
- Báo cho bác sĩ những diễn biến bất thường.
- Theo dõi tiến triển về cơ lực, sức bền.

2. Sau khi tập

- Người bệnh có đau và đau kéo dài.
- Theo dõi tiến triển của tầm vận khớp.
- Theo dõi hàng ngày và ghi vào hồ sơ bệnh án theo dõi
- Báo cho bác sĩ những diễn biến bất thường…
- Theo dõi tiến triển về cơ lực sức bền.

1. Trong khi tập: kết quả làm người bệnh bị đau thì ngừng tập và theo dõi sát người bệnh.

2. Sau khi tập: đau kéo dài và tình trạng toàn thân người bệnh có biểu hiện bất thường thì ngừng tập và xử trí tai biến đó.

Nếu đau chi trên nhiều thì sử dụng thuốc và các biện pháp vật lý giảm đau.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

35 Tập phối hợp hai tay

Mã đề xuất QT VLTL 35 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Bàn tay là công cụ đặc biệt giúp chúng ta thực hiện được các hoạt động sống hàng ngày. Chính vì vậy, khi giảm khả năng sử dụng hai tay để hoàn thành một công việc thì chúng ta cần chú ý điều trị, phục hồi chức năng sớm và tốt nhất.

2 Chỉ định

- Mất hoặc giảm khả năng phối hợp hai tay.
- Mất hoặc giảm cảm giác nửa người bên liệt, lãng quên nửa người bên liệt.
- Nhận thức kém, không tập trung vào hai vật cùng một lúc.

3 Chống chỉ định

Người bệnh đang trong giai đoạn cấp của bệnh.

4 Thận trọng

Vật nhỏ, dây và vật sắc chỉ dùng khi kiểm soát nguy cơ; điều chỉnh độ khó theo nhận thức và chức năng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Vật chuyển tay, nắp, cúc lớn an toàn.

5.4 Trang thiết bị

Bàn ghế và dụng cụ hoạt động trị liệu.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Bước 1: Lượng giá khiếm khuyết của người bệnh

2. Bước 2: Phân tích ảnh hưởng của khiếm khuyết lên chức năng:

- Mất hoặc giảm khả năng sử dụng hai tay để hoàn thành công việc ?
- Mất hoặc giảm cảm giác?
- Mất hoặc giảm tri giác, nhận thức?

3. Bước 3: Lập mục tiêu điều trị tổng quát thích hợp. Sử dụng 2 tay có hiệu quả để hoàn thành công việc.

4. Bước 4: Lập chương trình điều trị theo mục tiêu.

5. Bước 5: Thực hiện chương trình điều trị:

- Vỗ tay
- Chuyển vật từ tay này sang tay kia
- Kéo hai vật rời ra
- Bê vật bằng hai tay (ngửa bàn tay)
- Xoay nắp
- Xâu chuỗi hạt
- Mở cúc áo

6. Bước 6: Đánh giá hiệu quả của chương trình điều trị

Đánh giá sau tập luyện 1 tuần, 2 tuần, 4 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm...

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

1. Trong khi tập

- Xem người bệnh có mệt, khó chịu.
- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở và tình trạng toàn thân.
- Theo dõi hàng ngày và ghi vào hồ sơ bệnh án theo dõi
- Báo cho bác sĩ những diễn biến bất thường.

2. Sau khi tập

- Người bệnh có mệt kéo dài.
- Theo dõi tiến triển của tầm vận khớp.
- Theo dõi hàng ngày và ghi vào hồ sơ bệnh án theo dõi
- Báo cho bác sĩ những diễn biến bất thường…

1. Trong khi tập: kết quả làm người bệnh bị mệt thì ngừng tập và theo dõi sát người bệnh.

2. Sau khi tập: mệt kéo dài và tình trạng toàn thân người bệnh có biểu hiện bất thường thì ngừng tập và xử trí tai biến đó.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

36 Tập sinh hoạt hằng ngày với dụng cụ trợ giúp

Mã đề xuất QT VLTL 36 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

1. Định nghĩa

Dụng cụ trợ giúp thích nghi là những sản phẩm, dụng cụ, trang thiết bị hoặc hệ thống kỹ thuật được người khuyết tật, được chế tạo đặc biệt hoặc có sẵn ngoài thị trường, dành để phòng ngừa, hỗ trợ cho người khuyết tật độc lập càng nhiều càng tốt trong đời sống hàng ngày.

2. Các loại dụng cụ

2.1. Dụng cụ để điều trị và tập luyện: Thanh song song, gối và nệm chống loét

2.2. Dụng cụ dành để chăm sóc cá nhân và bảo vệ

Dụng cụ dành cho tiểu không tự chủ; quần áo thích nghi và dụng cụ mặc cởi quần áo; ghế ngồi và miếng nâng bàn cầu; ghế ngồi; ghế khoét lỗ để ngồi tắm hoặc đi vệ sinh; ghế ngồi và thảm để tắm chống trượt; thanh tựa để đi vệ sinh; dụng cụ để tắm rửa, để lau, đề tắm bằng vòi sen

2.3 Dụng cụ để vận động cá nhân

Ván dịch chuyển, thang dây; miếng nâng người; gậy, khung tập đi; xe lăn, xe đạp ba bánh đẩy tới bằng hai cánh tay;

2.4. Dụng cụ dành cho những sinh hoạt gia đình

Bộ đồ ăn thích nghi; vòng để dĩa và dĩa có cái chặn; chậu rửa bát; chổi; kéo

2.5. Sắp xếp và dụng cụ thích nghi cho nhà cửa và các loại nhà khác

Bàn, chỗ ngồi và giường điều chỉnh được; miếng gỗ nâng chân tủ, chân giường; thanh tựa; thiết bị mở và đóng các cửa ra vào, cửa sổ và màn; vòi nước có tay gạt; thang máy và máy nâng.

2.6.Dụng cụ để giao tiếp, thông tin và hệ thống tín hiệu

Kính lúp; giá để đọc sách và giá kê sách; dụng cụ lật trang giấy; cái dẫn bàn tay để viết; điện thoại; máy vi tính; bảng giao tiếp và hệ thống diễn tả thay lời nói.

2 Chỉ định

Người khuyết tật mất hoặc giảm khả năng thực hiện các chức năng sinh hoạt hàng ngày do bệnh tật mắc phải, tai nạn hoặc bẩm sinh.

3 Chống chỉ định

Người bệnh đang trong giai đoạn cấp của bệnh.

4 Thận trọng

Đánh giá nuốt trước tập ăn nếu nguy cơ sặc; kiểm soát nhiệt nước, điện và té ngã khi tập sinh hoạt; tôn trọng riêng tư.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Dụng cụ ăn, mặc, vệ sinh thích nghi.

5.4 Trang thiết bị

Tay vịn, phương tiện di chuyển và môi trường sinh hoạt an toàn.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Bước 1: Lượng giá khiếm khuyết của người bệnh

2. Bước 2: Phân tích ảnh hưởng của khiếm khuyết lên chức năng:

Mất hoặc giảm khả năng ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo, vui chơi giải trí?

3. Bước 3: Lập mục tiêu điều trị tổng quát thích hợp.

Sử dụng các dụng cụ trợ giúp thích hợp cho các sinh hoạt hàng ngày

4. Bước 4: Lập chương trình điều trị theo mục tiêu.

5. Bước 5: Thực hiện chương trình điều trị

Tập ăn, uống nước bằng cốc, rửa tay, mặt, vệ sinh, cởi mặc quần áo:: tập với các dụng cụ thích nghi.

6. Bước 6: Đánh giá hiệu quả của chương trình điều trị

Đánh giá hiệu quả sau sử dụng 1 tuần, 2 tuần, 4 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm...

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Nếu thấy đỏ da, đau ở các điểm tỳ đè thì cần kiểm tra, chỉnh sửa lại cho phù hợp.

- Đỏ da, loét do tì đè, đau giữa dụng cụ và vùng da tiếp xúc.

- Xử trí: Tránh tiếp tục tì đè lên vết đỏ da, loét do tì đè.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

37 Tập phát âm

Mã đề xuất QT VLTL 37 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

- Định nghĩa: Tập phát âm là cách giúp trẻ phát ra các âm thanh trong quá trình giao tiếp.

- Sau khi đã nghe và phân biệt được các âm thanh khác nhau trẻ sẽ khám phá cách tạo nên các âm thanh đó. Lúc đầu trẻ học cách phân biệt nguyên âm trước sau đó đến các phụ âm.

2 Chỉ định

- Trẻ nói khó: Bại não

- Trẻ nói ngọng, nói lắp

- Trẻ chậm phát triển tinh thần, chậm phát triển ngôn ngữ

- Trẻ tự kỷ

3 Chống chỉ định

Nguồn không nêu chống chỉ định tuyệt đối riêng. Hoãn hoặc điều chỉnh khi tình trạng chưa ổn định hoặc không dung nạp.

4 Thận trọng

Đánh giá nghe, nhận thức, giọng và vận động miệng để chọn bài; khó thở hoặc nghi bệnh thực thể cần khám chuyên khoa.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định; người thực hiện được đào tạo ngôn ngữ trị liệu, có phạm vi hành nghề và phân công phù hợp; người chăm sóc hỗ trợ bài đã được hướng dẫn.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Thẻ âm, tranh, gương, vật liệu theo tuổi.

5.4 Trang thiết bị

Phòng yên tĩnh và bàn ghế phù hợp.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra hồ sơ: đối chiếu chỉ định can thiệp và tên trẻ

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng tên trẻ với phiếu tập

3. Thực hiện kỹ thuật: Áp dụng 4 kỹ năng cơ bản

- Nghe: Dạy trẻ cách phân biệt âm đúng và sai, giúp trẻ bắt chước được âm của người hướng dẫn chính xác hơn.

- Nhìn: Yêu cầu trẻ quan sát cử động của các cơ quan phát âm giúp trẻ tạo vị trí đúng của các âm (Có thể dùng gương). Phân tích sự đúng hoặc sai trong cách phát âm của trẻ.

- Xúc giác: Trẻ cảm giác về sự rung hay không của dây thanh với các âm khác nhau. Trẻ cảm nhận được luồng hơi nhiều hay ít, mạnh hay nhẹ của các âm khác nhau.

- Cảm giác: Trẻ cảm nhận về các âm mình tạo ra đúng hay sai.

Chú ý: Bắt đầy dạy từ một nguyên âm hoặc phụ âm. Sau khi phát âm tốt mới chuyển sang từ, cụm từ, các câu và cuối cùng là hội thoại.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Sự tiến bộ của trẻ sau mỗi đợt can thiệp.

1. Trong khi tập: kết quả làm người bệnh bị mệt thì ngừng tập và theo dõi sát người bệnh.

2. Sau khi tập: mệt kéo dài và tình trạng toàn thân người bệnh có biểu hiện bất thường thì ngừng tập và xử trí tai biến đó.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

38 Tập cho người bệnh thất ngôn

Mã đề xuất QT VLTL 38 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

- Định nghĩa thất ngôn là tình trạng rối loạn ngôn ngữ do tổn thương bán cầu não

- Thất ngôn bao gồm:

+ Rối loạn một hoặc nhiều chức năng về hiểu lời nói, hiểu chữ viết, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng chữ viết.

+ Rối loạn về một hoặc nhiều lĩnh vực ngôn ngữ: âm vị học, hình thái học, ngữ nghĩa học và dụng học.

- Các rối loạn này đều có liên quan đến khu vực tổn thương của não.

2 Chỉ định

Người bệnh có rối loạn về giao tiếp do tổn thương bán cầu não.

3 Chống chỉ định

Rối loạn giao tiếp không do thất ngôn cần đánh giá phân biệt và chương trình phù hợp, không phải lý do từ chối hỗ trợ.

4 Thận trọng

Giao tiếp câu ngắn, đủ thời gian chờ, công cụ thay thế; không nhầm thất ngôn với giảm nhận thức, tránh ép trả lời.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định; người thực hiện được đào tạo ngôn ngữ trị liệu, có phạm vi hành nghề và phân công phù hợp; người chăm sóc hỗ trợ bài đã được hướng dẫn.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Thẻ hình, chữ, đồ quen, bảng giao tiếp.

5.4 Trang thiết bị

Phòng yên tĩnh, bàn ghế, hỗ trợ giao tiếp khi cần.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

1. Kiểm tra người bệnh

- Hội thoại:

Hỏi người bệnh tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ và ghi câu trả lời vào phiếu đánh giá.

Người bệnh tự kể về gia đình, công việc, tiền sử bệnh. Tự kể 01 bức tranh có chủ đề mà người đánh giá đưa ra.

- Đánh giá nghe hiểu:

Nghe và chỉ vào các bức tranh.

Nghe và chỉ vào các bộ phận cơ thể. Làm theo các mệnh lệnh từ dễ đến khó.

- Lời nói: Làm theo các cử động miệng của người hướng dẫn.

Nói chuỗi tự động số hoặc chữ.

Nhắc lại các phát ngôn vừa nghe thấy

Đọc chữ

Trả lời định danh

Định danh hình vẽ.

- Hiểu ngôn ngữ viết: Phân biệt ký hiệu và từ. Chọn từ khi được nghe. Hiểu từ khi nghe đánh vần. So cặp tranh và chữ.

- Viết:

Viết chính tả. Viết về bản thân

2. Thực hiện kỹ thuật

- Tùy vào dạng thất ngôn dạy người bệnh nhằm vào những chức năng ngôn ngữ bị tổn thương.

- Lồng ghép việc dạy vào các hoạt động hàng ngày.

- Dạy từ dễ đến khó.
- Sử dụng kỹ năng nhắc.
- Phối hợp nhiều những phương pháp giao tiếp hỗ trợ khác: tranh ảnh cử chỉ…

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Có thể chia các phần đánh giá trong nhiều buổi.

1. Trong khi tập: người bệnh bị mệt thì ngừng tập và theo dõi sát người bệnh.

2. Sau khi tập: mệt kéo dài và tình trạng toàn thân người bệnh có biểu hiện bất thường thì ngừng tập và xử trí tai biến đó.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

39 Lượng giá hoạt động sinh hoạt hằng ngày

Mã đề xuất QT VLTL 39 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Lượng giá hoạt động sinh hoạt hằng ngày xác định mức độc lập, mức trợ giúp và mục tiêu phục hồi. Chọn đúng phiên bản Barthel, Katz hoặc công cụ được bệnh viện chấp nhận; chấm theo hướng dẫn riêng, không trộn điểm 0–6 với A–G hoặc dùng ba mức điểm cho mọi mục Barthel.

2 Chỉ định

Đánh giá thực hiện hoạt động chức năng trong sinh hoạt hàng ngày được chỉ định cho mọi trường hợp khuyết tật, đặc biệt khi muốn đánh giá mức độ cần hỗ trợ, nhu cầu cần phục hồi chức năng và đánh giá kết quả của chương trình can thiệp. Tuy nhiên, nó thường được chỉ định nhiều hơn trong các trường hợp sau:

- Người bệnh liệt
- Người khuyết tật thần kinh, tâm thần
- Người khuyết tật chậm phát triển trí tuệ
- Người bệnh mắc bệnh mãn tính, suy giảm sức khỏe

3 Chống chỉ định

Nguồn không nêu chống chỉ định tuyệt đối riêng. Hoãn hoặc điều chỉnh khi tình trạng chưa ổn định hoặc không dung nạp.

4 Thận trọng

Dùng đúng thang và phiên bản, ghi từng mục và mức trợ giúp; bảo vệ chống ngã khi quan sát đi lại, chuyển tư thế.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Phiếu thang đo đúng phiên bản, hướng dẫn chấm.

5.4 Trang thiết bị

Dụng cụ sinh hoạt và khu quan sát an toàn.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Chọn thang đã được bệnh viện chấp nhận, đúng phiên bản, hướng dẫn chấm; giải thích và đồng thuận.

Bước 2. Hỏi mức hoạt động và trợ giúp từ người bệnh, người chăm sóc, hồ sơ; ghi nguồn thông tin.

Bước 3. Quan sát từng hoạt động khi an toàn, bảo vệ chống ngã; không yêu cầu vượt giới hạn chịu tải hoặc thử ăn khi nguy cơ sặc chưa được đánh giá.

Bước 4. Chấm đúng hướng dẫn từng mục, tổng và mức trợ giúp; ghi mục chưa quan sát và lý do, không tự gán điểm thiếu.

Bước 5. Giải thích, đặt mục tiêu và lịch đánh giá lại; dùng cùng phiên bản để theo dõi.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Kỹ thuật này không có các biến chứng cần theo dõi

Kỹ thuật đánh giá này không có tai biến cần xử trí

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

40 Lượng giá chức năng lao động và hướng nghiệp

Mã đề xuất QT VLTL 40 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

- Theo Tổ chức Lao động quốc tế, lượng giá hướng nghiệp là nhằm xác định mối quan tâm, khả năng, thái độ và kỹ năng của một cá nhân để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, nhu cầu và tiềm năng trong công việc của cá nhân đó.

- Lượng giá hướng nghiệp có thể sử dụng các kỹ thuật đã được chuẩn hóa (các bài kiểm tra) hoặc các cách tiếp cận thông thường (qua phỏng vấn, quan sát). Đây là một phần của quá trình hướng dẫn nghề nghiệp và thường dẫn đến các khuyến nghị cho đào tạo nghề hoặc tuyển dụng.

- Lượng giá hướng nghiệp giúp người khuyết tật lựa chọn nghề nghiệp hoặc học nghề phù hợp, giúp các nhà tư vấn, các chuyên gia phục hồi chức năng và cán sự việc làm thực hiện hiệu quả hơn, giúp cho các giáo viên dạy nghề điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của người khuyết tật, giúp các nhân viên hành chính sử dụng nguồn lực thông minh hơn và giúp các nhà tuyển dụng có lực chọn tốt hơn.

- Lượng giá hướng nghiệp được thực hiện khi người khuyết tật còn ở trong độ tuổi lao động, có khả năng độc lập trong sinh hoạt và có khả năng giao tiếp ở mức hiểu người khác hoặc thể hiện được nhu cầu tình cảm mà người khác hiểu được. Lượng giá hướng nghiệp giúp cho phục hồi chức năng có mục tiêu cụ thể hơn và là cơ sở để tư vấn hướng nghiệp trước khi người bệnh ra khỏi chương trình can thiệp.

2 Chỉ định

Lượng giá hướng nghiệp có thể được thực hiện tại các cơ sở Phục hồi chức năng hoặc tại cộng đồng.

* Tại các cơ sở Phục hồi chức năng: lượng giá hướng nghiệp được thực hiện nhằm chuẩn bị cho người khuyết tật trưởng thành tái hòa nhập/hòa nhập xã hội.

* Tại cộng đồng: lượng giá hướng nghiệp là bước đầu tiên để giúp người khuyết tật trưởng thành tìm được việc làm phù hợp, hòa nhập cộng đồng.

3 Chống chỉ định

Người không ở trong độ tuổi lao động

4 Thận trọng

Tự nguyện, bảo mật và chọn mục tiêu việc làm thực tế; kết quả lượng giá không tự thay giấy khám sức khỏe.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Phiếu phỏng vấn và công cụ nghề nghiệp.

5.4 Trang thiết bị

Khu riêng tư và mô phỏng công việc an toàn.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

Trình tự lượng giá hướng nghiệp tham khảo từ bản bệnh viện, gồm các nội dung sau:

1. Phỏng vấn người khuyết tật

2. Xem xét giấy tờ về kinh nghiệm làm việc. Xem xét việc học hành hoặc các giấy tờ liên quan tới giáo dục hoặc các khóa tập huấn đã tham gia

Đánh giá sức khỏe và yêu cầu công việc; chứng nhận đủ sức khỏe lao động chỉ do người và cơ sở có thẩm quyền thực hiện.

4. Sử dụng các trắc nghiệm về năng lực và năng khiếu và, nếu có thể, các trắc nghiệm tâm lý.

5. Tìm hiểu một cách chắc chắn hoàn cảnh cá nhân và gia đình

6. Tìm hiểu năng khiếu và sự phát triển khả năng qua kinh nghiệm làm việc và qua các cách khác

7. Các trắc nghiệm công việc, hoặc bằng lời hoặc bằng cách khác khi cần thiết.

8. Phân tích khả năng thể chất trong mối tương quan với yêu cầu của công việc và khả năng cải thiện năng lực đó.

9. Cung cấp thông tin liên quan đến các cơ hội việc làm và đào tạo nghề liên quan đến trình độ, khả năng về thể chất, năng khiếu, sự ưa thích và kinh nghiệm của cá nhân, nhu cầu của thị trường việc làm.

10. Thảo luận cùng người khuyết tật về những việc phù hợp với họ để họ là người ra quyết định

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Không cần theo dõi sau khi lượng giá. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh tâm lý làm người khuyết tật thất vọng.

Không có tai biến cần xử trí

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

41 Điều trị bằng sóng xung kích

Mã đề xuất QT VLTL 41 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Năng lượng cơ học theo thiết bị: phân biệt sóng xung kích hội tụ và sóng áp lực hướng tâm; không dùng áp suất bar thay mật độ năng lượng mJ/mm². Liều theo đúng máy.

2 Chỉ định

- Đau cân, gân chi thể.

- Đau cơ khớp không do chấn thương cấp, viêm cấp.

3 Chống chỉ định

- Dạng chảy máu hoặc nguy cơ chảy máu.

- Chấn thương cấp.

- Khối u ác tính.

- Trực tiếp lên đầu xương trẻ em, gãy xương hoặc nghi ngờ gãy xương, thai nhi.

4 Thận trọng

Xác định máy hội tụ hay hướng tâm, thuốc chống đông và nguy cơ chảy máu; không quy đổi bar thành mật độ năng lượng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Gel, khăn và vật tư làm sạch đầu phát.

5.4 Trang thiết bị

Máy được nhận diện hội tụ hoặc hướng tâm và đầu phát tương thích.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu. Kiểm tra da, cảm giác, tưới máu và vật cản vùng điều trị theo yêu cầu phương thức.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Đối chiếu lần cuối theo mục 5.9, vệ sinh tay, kiểm tra phương tiện và bố trí tư thế an toàn trước thao tác.

- Bôi gel lên bề mặt da vùng điều trị.

- Đặt đầu phát sóng lên vị trí và tiến hành điều trị theo chỉ định.

- Hết thời gian điều trị: tắt máy, Lau vùng da điều trị và đầu phát sóng. Kiểm tra vùng điều trị, thăm hỏi người bệnh, ghi chép hồ sơ.

Kết thúc: đánh giá lại đau, chức năng; hỗ trợ tư thế an toàn, vệ sinh phương tiện, ghi bài tập hoặc thông số, mức trợ giúp và đáp ứng, bàn giao khi cần.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Cảm giác và phản ứng của người bệnh.

- Đau tăng hoặc sưng nề ngừng điều trị, theo dõi kiểm tra.
- Chảy máu dưới da: ngừng điều trị, theo dõi và xử trí theo phác đồ.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Sự cố điện: ngắt nguồn an toàn trước tiếp cận, gọi hỗ trợ, cấp cứu theo tình trạng. Bỏng hoặc đau rát: dừng nguồn năng lượng, đánh giá, báo bác sĩ; cách ly máy lỗi và báo bộ phận thiết bị.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.

42 Điều trị bằng sóng ngắn

Mã đề xuất QT VLTL 42 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Sóng ngắn sử dụng trường điện từ cao tần. Tần số, chế độ và công suất theo nhãn máy và chỉ định; không dùng số 13,7 MHz, 27,3 MHz, 39,5 MHz của bản cũ làm cài đặt.

- Cơ chế tác dụng chính: tương tác điện trường cao tần đối với tổ chức sống và tăng nhiệt các mô bằng cơ chế nội nhiệt.
- Chỉ sử dụng điều trị cục bộ.

2 Chỉ định

- Chống viêm.
- Giảm sưng nề và máu tụ sau chấn thương, phẫu thuật.
- Tăng dinh dưỡng tổ chức tại chỗ.
- Giảm đau cục bộ.

3 Chống chỉ định

- Người có mang máy tạo nhịp tim.
- Các loại u ác tính u máu.
- Lao chưa ổn định.
- Bệnh máu, đang chảy máu hoặc đe dọa chảy máu.
- Thai nhi.
- Cơ thể suy kiệt nặng, suy tim, đang sốt cao.
- Người quá mẫn cảm với điện trường cao tần.
- Điều trị trực tiếp qua não, tủy sống, tim, vùng cơ thể có kim loại.

4 Thận trọng

Kiểm soát kim loại, thiết bị cấy ghép và vật liệu ẩm. Không chỉnh điện cực khi đang phát; vùng an toàn theo thiết bị và phòng thực tế.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ PHCN chỉ định và đánh giá; kỹ thuật viên PHCN có năng lực, phạm vi hành nghề và phân công phù hợp thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ theo nhu cầu. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ bài đã được hướng dẫn, không thay người thực hiện tại bệnh viện.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc riêng. Thuốc điều trị hoặc cấp cứu chỉ dùng theo y lệnh và phác đồ bệnh viện.

5.3 Vật tư

Đệm cách ly theo hướng dẫn, không ẩm.

5.4 Trang thiết bị

Máy sóng ngắn, điện cực, cáp, phương tiện kiểm tra theo hướng dẫn.

5.5 Người bệnh

Giải thích mục tiêu, cách phối hợp; đánh giá đau, chức năng, dung nạp, sinh hiệu theo tình trạng; tư thế an toàn và kín đáo. Báo ngay đau, chóng mặt hoặc khó chịu. Kiểm tra da, cảm giác, tưới máu và vật cản vùng điều trị theo yêu cầu phương thức.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án, chỉ định và kế hoạch PHCN, kết quả liên quan và phiếu theo dõi. Ghi vùng, bên, mục tiêu, giới hạn vận động hoặc thông số máy khi áp dụng.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo chỉ định, dung nạp và hướng dẫn kỹ thuật hoặc thiết bị; ghi thời gian thực tế. Khoa xác nhận định mức trước ban hành.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu VLTL và PHCN phù hợp, đủ không gian an toàn, sẵn phương tiện gọi hỗ trợ. Tại giường chỉ khi đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng với phiếu chỉ định; kiểm tra kỹ thuật, vùng, bên, tình trạng, chống chỉ định, y lệnh và phương tiện. Giải quyết sai khác trước bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra chỉ định, thai kỳ, cấy ghép, kim loại, da, cảm giác và độ khô vùng điều trị.

Bước 2. Kiểm tra máy, cáp, vùng an toàn; chọn tư thế và điện cực, vị trí, khoảng cách theo hướng dẫn và chỉ định.

Bước 3. Cài chế độ, công suất, thời gian đúng đơn vị; kiểm tra phát bằng phương pháp nhà sản xuất cho phép.

Bước 4. Theo dõi nóng, đau rát và bất thường; dừng phát, đưa công suất về không trước chỉnh điện cực.

Bước 5. Kết thúc theo máy, kiểm tra da, ghi thông số, thời gian, đáp ứng; vệ sinh và báo sự cố.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

- Cảm giác và phản ứng của người bệnh.

Theo dõi máy và điện cực; dừng phát, đưa công suất về không trước chỉnh theo hướng dẫn.

- Điện giật: tắt máy, xử trí điện giật.

- Bỏng tại chỗ: xử trí như xử trí bỏng nhiệt.

Kiểm soát phơi nhiễm bằng bố trí phòng, vùng an toàn, cảnh báo và đánh giá theo thiết bị cùng quy định áp dụng. Không coi 3 mét hoặc xét nghiệm tế bào máu mỗi 6 tháng là quy tắc chung cho mọi máy.

Theo dõi dung nạp trong và sau buổi, ghi đau, chức năng và bất thường. Đau ngực, khó thở, ngất, dấu hiệu thần kinh mới hoặc bất ổn sinh hiệu: ngừng, đưa về tư thế an toàn, gọi bác sĩ và kích hoạt cấp cứu theo tình trạng. Không tự dùng thuốc ngoài y lệnh.

Sự cố điện: ngắt nguồn an toàn trước tiếp cận, gọi hỗ trợ, cấp cứu theo tình trạng. Bỏng hoặc đau rát: dừng nguồn năng lượng, đánh giá, báo bác sĩ; cách ly máy lỗi và báo bộ phận thiết bị.

Tài liệu đối chiếu của quy trình

Tài liệu VLTL năm 2024 của bệnh viện; QĐ3023/QĐ-BYT về đề cương. Xem căn cứ và giới hạn ở đầu bộ. Khoa đối chiếu kỹ thuật tương ứng trong bộ PHCN năm 2025, bổ sung hướng dẫn đúng model hoặc thang đo trước ban hành.